



Mapeo de actores y diálogo estratégico para la gobernanza de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

Mapeo de actores y diálogo estratégico para la gobernanza de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

Washington, D.C., 2025

*Mapeo de actores y diálogo estratégico para la gobernanza de los sistemas de información de recursos humanos para la salud
(Fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas)*

OPS/HSS/HR/25-0010

© Organización Panamericana de la Salud, 2025

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Ilustración de portada: © GAMBOCORP MR DESIGN

Diseño: © Emilia Palomeque

Índice

Agradecimientos	v
Abreviaciones.....	vi
Presentación	vii
Resumen.....	viii
Dimensiones relevantes y fuentes de información.....	viii
Los registros administrativos como fuentes de datos.....	ix
Metodología	ix
Conclusiones.....	x
Introducción	1
¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?	1
Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas.....	2
Antecedentes	3
Hacia un sistema de información de recursos humanos para la salud	3
Dimensiones relevantes de recursos humanos para la salud	4
La importancia de la gobernanza: ¿por qué un mapeo de actores?	7
Fuentes de datos: censos, encuestas y registros administrativos	7
La importancia de la gobernanza	9
Registros involucrados en el desarrollo de un sistema de información de recursos humanos para la salud	11
Registros de referencia	12
Registros auxiliares	13
Metodología para el mapeo de actores y diálogo estratégico	17
Objetivos.....	17
Etapas	17
Equipo para la conformación de un sistema de información de recursos humanos para la salud	18
Propuesta de matriz de relevamiento de actores de recursos humanos para la salud	19

Guía operativa para el desarrollo del mapeo de actores	21
Autoevaluación y mapeo de actores.....	22
Relevamiento de datos de registros	27
Concertación y formalización de acuerdos estratégicos.....	28
Revisión de la hoja de ruta.....	29
Conclusiones	31
Referencias.....	33
Anexos	35
Anexo 1. Guía de autoevaluación de la Unidad Estratégica de Recursos Humanos para la Salud	35
Anexo 2. Guías para el relevamiento de registros oportunos para la consolidación de un sistema de información de recursos humanos para la salud	38
Anexo 3. Propuesta de matriz de relevamiento de actores de recursos humanos para la salud	51
Anexo 4. Secuencia sugerida para la implementación y el seguimiento de la hoja de ruta del mapeo de actores	54
Figuras	
1. Niveles de actividad del personal de salud según las cuentas nacionales del personal de salud	5
2. Ejemplo de diagrama de mapeo de actores	20
Cuadros	
1. Personal de salud según categoría, área de formación y sector de actividad	5
2. Conformación del equipo coordinador.....	18
Recuadros	
1. El sector de la seguridad social y el rol de los organismos reguladores	19
2. Guía operativa	21
3. Áreas involucradas según misión y función.....	24
4. Recomendaciones para entrevistas	28

Agradecimientos

Esta publicación fue elaborada por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR, por sus siglas en inglés) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., bajo la dirección de Benjamín Puertas, jefe de la Unidad de HSS/HR. La coordinación de este esfuerzo estuvo a cargo de Ana Paula Cavalcante de Oliveira, especialista en Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, con el apoyo de las consultoras internacionales Isabel Duré y Mariana Lopes Galante. Este documento toma como base los aportes técnicos de Mario Dal Poz, del Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado del Río de Janeiro, con el apoyo de Juan Lucas Pereyra y Carolina Dursi.

La metodología se nutre de tres experiencias de consultoría sobre mapeo de actores de sistemas de información de recursos humanos para la salud realizadas en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile y Paraguay por Juan Lucas Pereyra entre el 2021 y el 2024, con el apoyo de los asesores de la OPS Felipe Roberto Sánchez, Mario Cruz Peñate y Alejandra Carrillo Roa.

Se agradece especialmente a Gisele Almeida, asesora de evidencia e información de recursos humanos para la salud en la Unidad de HSS/RH de la OPS, por el liderazgo ejercido para la realización de este documento. Por último, se agradece a Leah Marie Richards, Mónica Padilla y Alejandra Carrillo Roa por su revisión y aportes sobre la metodología propuesta para el mapeo de actores.

Abreviaciones

CIUO	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
CNPS	Cuentas nacionales del personal de salud
FTS	Fuerza de trabajo en salud
MS	Ministerio de Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
RHS	Recursos humanos para la salud
RRAA	Registros administrativos
SIRHS	Sistema de información de recursos humanos para la salud
SIS	Sistema de información para la salud
TIC	Tecnologías de la información y las comunicaciones

Presentación

Este documento describe la metodología propuesta para el mapeo de actores que desarrolló la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR, por su sigla en inglés), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dicha metodología es parte de la iniciativa para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS), que busca ayudar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y políticas en salud.

La metodología de mapeo de actores y de diálogo estratégico presentada en este documento se propone como una herramienta clave para acompañar el fortalecimiento de la gobernanza orientada a la conformación de un SIRHS. Ofrece un camino para identificar y convocar a los actores que pueden contribuir a su desarrollo, promoviendo procesos de articulación y colaboración interinstitucional. Invitamos a los Estados Miembros y a los distintos actores del sector a recorrer este camino y establecer las bases de acuerdos que permitan avanzar hacia un sistema sostenible y robusto, capaz de generar evidencia para orientar la toma de decisiones y las políticas en salud.

E. Benjamín Puertas,

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud

Resumen

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son un tipo de sistemas de información para la salud (SIS) que involucran procesos estandarizados para recopilar, almacenar, administrar, analizar, usar y disseminar datos que produzcan información adecuada, oportuna y de calidad sobre el tamaño, la composición y la ubicación de los recursos humanos para la salud (RHS) a nivel nacional. Se trata de datos demográficos, de capacitación y de patrones de migración, entre otros.

Los SIRHS constituyen un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión de los RHS capaces de optimizar las comunicaciones en este ámbito y ayudar en la toma de decisiones a mediano y largo plazo. Su construcción involucra una serie de decisiones y acciones a niveles estratégicos y operativos que cada país orienta y organiza a partir de sus estructuras previas y capacidades actuales. No existe una receta única, por lo que cada país debe elaborar su propia hoja de ruta.

La iniciativa de fortalecimiento de los SIRHS, de la que forma parte esta metodología, busca apoyar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y el diseño y la implementación de las políticas de salud.

Uno de los principales desafíos que se observan a la hora de construir información oportuna para la medición de los RHS es que gran parte de los SIS, así como los pertenecientes a otras áreas del Estado, se han centrado en preparar soluciones aisladas en detrimento de una estrategia de gobernanza basada en la convergencia de acciones, la construcción de estándares y la búsqueda de una arquitectura de interoperabilidad de bases de datos que facilite el acceso a información pertinente y confiable.

Este documento propone la realización de un mapeo de los actores involucrados en los de registros administrativos de RHS, como punto de partida para utilizar dichos registros con fines estadísticos que permitan avanzar hacia la consolidación de un SIRHS. La metodología de mapeo de actores tiene como objetivo identificar a los propietarios de los datos y a los actores que tienen intereses en ellos, y trazar una hoja de ruta de trabajo conjunto entre los diferentes responsables de los datos y de la información en el ámbito de los RHS. Esto se logra mediante el diálogo estratégico, la detección de puntos de interoperabilidad y el establecimiento de acuerdos de colaboración entre estos actores. De este modo, se propicia una caracterización o representación visual de las personas, los grupos, las instituciones o las organizaciones que se nuclean en torno a, o intervienen en, un asunto, un territorio o un problema determinado.

Dimensiones relevantes y fuentes de información

Avanzar en el fortalecimiento de la información sobre los RHS implica considerar una serie de elementos, y para esto resulta necesario lo siguiente: i) establecer consensos sobre qué medir, ii) promover el uso de múltiples fuentes de información, iii) mejorar la comparabilidad, y iv) desarrollar herramientas y la capacidad necesaria.

Se consideran dimensiones relevantes para el estudio de la fuerza de trabajo en salud la integración de los elementos de formación, la ocupación actual y el sector de actividad:

- **Formación:** se refiere al proceso educativo (formal e informal) que los individuos emprenden para adquirir las habilidades necesarias para desempeñarse de manera competente en un puesto de trabajo.
- **Ocupación:** se refiere a las tareas y funciones que las personas realizan en un trabajo.
- **Sector de actividad:** hace referencia a las actividades de los establecimientos o empresas donde las personas trabajan.

Los registros administrativos como fuentes de datos

Los registros administrativos pueden definirse como procesos de captación permanente o sistemática de información sobre hechos, personas o acciones que se encuentran bajo la regulación de algún organismo público, y que se actualizan permanentemente debido a que están asociados a procedimientos administrativos que requieren sistematizar esa información.

Estos registros se encuentran dispersos y su gestión está a cargo de actores diversos. Por lo tanto, la consolidación de un SIRHS implica atender, como eje central, el problema de la gobernanza y garantizar la capacidad de tomar decisiones acerca de los registros y su vinculación: entablar alianzas y mecanismos sostenibles de intercambio de datos, información, conocimiento, inversión y financiamiento, e impulsar la implementación de sistemas de información y salud digital interoperables, abiertos y sostenibles.

Los registros que se van a utilizar en la construcción del SIRHS se clasifican en registros de referencia (registros de habilitación de profesionales y registro de establecimientos de salud) y registros auxiliares (nóminas de personal, identidad de las personas, titulaciones, información tributaria, registros migratorios, pensiones y jubilaciones, etc.).

Para integrar los registros en un SIRHS, se requiere consolidar una infraestructura ligada al reconocimiento de varios elementos:

1. Identificar quién es el “propietario” de los datos, quién los utiliza y quién puede tomar decisiones sobre ellos.
2. Reconocer dónde se almacenan los datos y cómo se organiza el acceso a ellos.
3. Establecer mecanismos para garantizar la calidad, interoperabilidad y sostenibilidad de los datos.
4. Proteger los datos de amenazas como su accesibilidad no autorizada o su uso inapropiado.
5. Determinar las herramientas, los recursos y las destrezas necesarios para gestionar y utilizar los datos de forma eficaz.

Metodología

La metodología del mapeo de actores y diálogo estratégico de los SIRHS que aquí se propone tiene como objetivo elaborar un listado de los actores involucrados en ese ámbito; registrar sus relaciones, acciones, intereses, posibilidades y expectativas al respecto, e involucrarlos en un proceso colaborativo estratégico hacia un SIRHS integrado.

Para ello, el proceso se configura en seis etapas, a saber:

1. Identificar el área encargada de liderar el proceso de mapeo de actores y el diálogo estratégico, que, idealmente, sería aquella instancia de gobierno que utilizará estratégicamente los datos para la planificación de los RHS.
2. Caracterizar el contexto de salud del país, sus metas en términos de políticas de salud, y el marco estratégico y de oportunidad en el que se propone el desarrollo de un SIRHS.

3. Reconocer la estructura político-administrativa del país y de su modelo de atención de la salud (sector público, privado y de seguridad social; grado de descentralización en la gestión y el financiamiento), así como de las áreas que gestionan registros relacionados con los RHS.
4. Determinar las características, la normativa y los convenios asociados a los registros administrativos de referencia y auxiliares, incluyendo su objetivo, sus alcances y su actualización.
5. Detectar actores interesados en información sobre RHS para diversos fines, como la planificación estratégica, la elaboración de estadísticas, la gestión de procesos administrativos o el desarrollo de la salud digital, así como las vinculaciones que estos ámbitos mantienen entre sí.
6. Conformar una mesa de trabajo que reúna a las áreas participantes del proceso de construcción y gestión de los datos relativos a los RHS, y elaborar la hoja de ruta del proceso.

Cada una de estas etapas cuenta con una guía para su operacionalización en el documento, así como orientaciones sobre cómo buscar actores clave para el desarrollo del SIRHS. La metodología del mapeo incluye entrevistas en profundidad a los actores para reconocer sus intereses y sumarlos al diálogo estratégico, y un análisis de las estructuras de sus bases de datos, sus condiciones para la interoperabilidad, su infraestructura tecnológica y las capacidades de los equipos que las gestionan. Se valorará el uso de estándares comunes nacionales e internacionales para garantizar comparabilidad de los datos.

Una vez realizada esta caracterización, se trazarán un mapa y un diagrama de actores y se propondrán opciones para estructurar la integración.

A continuación, se avanzará en el diálogo y en la elaboración de acuerdos de gestión y en la confección de una hoja de ruta común, con metas concretas y escalables y con indicadores de seguimiento.

La identificación de los actores no es un ejercicio puntual, sino la base de una hoja de ruta viva que evoluciona a medida que las instituciones perfeccionan sus funciones, armonizan las normas y crean confianza mutua. Así, se convierte en un producto compartido y sostenido conjuntamente por todos los actores que contribuyen al ecosistema de información sobre el personal de salud.

Conclusiones

La Organización Panamericana de la Salud ha destacado la necesidad de disponer de información para la planificación, la formulación de políticas y la toma de decisiones estratégicas en el sector de la salud. No obstante, uno de los principales desafíos es la fragmentación de los sistemas de información, que suelen operar de manera aislada y sin una estrategia de gobernanza unificada. Esta fragmentación limita la capacidad de integrar datos provenientes de diversas fuentes, lo que tiene como consecuencia la duplicación de esfuerzos y la dificultad para contar con información precisa, oportuna y actualizada sobre las dimensiones relevantes de los RHS.

La metodología de mapeo de actores desarrollada en este documento se presenta como la principal herramienta para fortalecer la gobernanza de cara a la conformación de un SIRHS. Se concibe desde una perspectiva continua e integradora: comienza en las áreas donde el Ministerio de Salud tiene mayor capacidad de rectoría, con lo cual se consolida el núcleo de gobernanza, y se expande progresivamente hacia otras áreas estratégicas tanto dentro como fuera del sector público. El mapeo de actores servirá para las siguientes finalidades:

- Explorar y comprender las relaciones entre los diversos actores involucrados en la gestión de RHS.
- Identificar necesidades específicas de información sobre RHS para determinar oportunidades de intercambio.

- Facilitar la coordinación multisectorial y la construcción de alianzas efectivas que mejoren el flujo de información.
- Optimizar los flujos de información mediante la formalización de convenios y la adopción de estándares comunes.

La metodología propuesta es flexible; incluso una implementación parcial puede ayudar a los países a comenzar a crear gobernanza y, con el tiempo, a transformar la coordinación en un sistema sostenible de datos sobre RHS.

Cada nación posee contextos administrativos, sanitarios y culturales específicos, así como una trayectoria en el desarrollo de SIRHS, elementos que determinarán distintos puntos de partida para la integración de las fuentes de datos. Por lo tanto, es imprescindible adaptar y validar la metodología de acuerdo con los objetivos de las políticas públicas, y las necesidades y capacidades locales.

Introducción

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son un tipo de sistemas de información para la salud (SIS) que involucran procesos estandarizados para recopilar, almacenar, administrar, analizar, usar y diseminar datos que produzcan información adecuada, oportuna y de calidad sobre el tamaño, la composición y la ubicación de los recursos humanos para la salud (RHS) a nivel nacional. Entre otros, incluyen datos demográficos, de capacitación y de patrones de migración.

Según la *Guía conceptual para el desarrollo de sistemas de información de SIRHS*, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos sistemas están conformados por normas, personas e instituciones que interactúan bajo la conducción y gobernanza de la autoridad nacional de salud. En ellos intervienen diversos actores, no solo del ámbito de la salud, sino también de la educación, el trabajo, las finanzas y otros ámbitos relacionados con la migración de profesionales de la salud.

Los SIRHS son un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión de los RHS, capaces de optimizar las comunicaciones en este ámbito y ayudar en la toma de decisiones a mediano y largo plazo. Su construcción involucra una serie de decisiones y acciones a niveles estratégicos y operativos, que cada país orienta y organiza a partir de sus estructuras previas y capacidades actuales. No existe una receta única, por lo que cada país debe desarrollar su propia hoja de ruta.

No obstante, para facilitar a los países la identificación de su línea de base respecto de los SIRHS, así como la construcción de un itinerario hacia un SIRHS robusto, existe una serie de recomendaciones y posibles pasos que dar. La iniciativa de fortalecimiento de los SIRHS, de la que forma parte esta metodología, busca apoyar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y el diseño y la implementación de las políticas de salud. Esta iniciativa se estructura en torno a tres ejes: gobernanza y cooperación regional; marco conceptual y técnico con metodologías y herramientas clave, y producción y uso estratégico de evidencia sobre la fuerza de trabajo en salud (FTS).

¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?

El conjunto de metodologías y herramientas fue creado para acompañar a las personas responsables de los trabajadores de salud de un país, que están en condiciones de influir en el desarrollo de políticas de RHS y en la asignación de recursos para el diseño y la implementación de SIRHS. Se trata, en suma, de un instrumento muy útil para los encargados de la toma de decisiones que buscan implementar un SIRHS con base en sus políticas de salud y buenas prácticas.

Este conjunto de metodologías y herramientas también será de utilidad para los planificadores, administradores y profesionales de la salud de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que trabajen con la FTS de su país y necesiten conocer la situación actual, los escenarios alternativos y las necesidades de desarrollo para lograr sistemas de salud resilientes.

Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas

El conjunto de metodologías y herramientas contiene una selección de guías, documentos, instrumentos y manuales prácticos desarrollados con base en la evidencia y la participación de los países de la Región de las Américas. Este conjunto está compuesto por el mapeo de actores, el mapeo de ocupaciones y la evaluación de madurez de los SIRHS. Tales materiales están alineados con las cuentas nacionales del personal de salud y orientados a apoyar la formulación de políticas informadas por evidencias dirigidas a respaldar un sistema de salud de calidad.

Si bien los recursos de este conjunto de metodologías y herramientas se centran en apoyar la cooperación técnica para que los países de las Américas puedan desarrollar sus SIRHS, resulta importante destacar que se trata de un cuerpo flexible, que se ajusta a las necesidades de los sistemas de salud de la Región a través de los aportes de una amplia gama de profesionales que trabajan en temas relacionados con la gestión y la planificación de la FTS.

Para facilitar el acceso y uso de estos recursos, el presente conjunto se ha estructurado en categorías a las que puede accederse a través del sitio web de la OPS (<https://www.paho.org/es/temas/evidencia-e-informacion-recursos-humanos-para-salud>) o mediante el código QR que aquí se presenta. En dicho sitio, el lector encontrará una lista de los títulos de cada documento, con un breve resumen de su contenido y una sección que describe a quién está dirigido cada uno. Los materiales incluyen orientación sobre la evaluación de la madurez de los SIRHS, el mapeo de los actores para la gobernanza de los datos de los RHS, las ocupaciones de los trabajadores de salud, y las cuentas nacionales del personal de salud, entre otros temas.



Antecedentes

Hacia un sistema de información de recursos humanos para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha destacado en el Plan de Acción para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la Salud 2019-2023 (1) que la información de salud es esencial en lo que se refiere a la acción, la investigación, la planificación, la toma de decisiones, la asignación de prioridades, la formulación de políticas y las operaciones, así como al seguimiento y la evaluación. El personal de salud representa uno de los ejes de los sistemas de salud, por lo tanto, la información respecto de su formación y disponibilidad es un componente relevante de los sistemas de información para la salud.

Además, la 69.^a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA69.19 del 2016 (*Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030*), instó a todos los Estados Miembros a establecer “un conjunto básico de datos relativos a los recursos humanos para la salud (...) y aplicar de manera progresiva las cuentas nacionales del personal de salud” (2). Asimismo, en el 2017, la 29.^a Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la *Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud* (3) y posteriormente, en el 2018, el Plan de Acción de dicha Estrategia (4).

La Estrategia del 2017 contempla, en su línea estratégica de acción 1: “Priorizar el desarrollo de sistemas de información sobre recursos humanos contextualizados a las necesidades nacionales y orientados a apoyar la formulación y el seguimiento de políticas, planes y programas de recursos humanos para la salud”. En el Plan de Acción acordado con los países, se estableció como indicador 1.2.3: “Número de países con un sistema nacional de información de recursos humanos para la salud en funcionamiento que responda a las necesidades de planificación, realice el monitoreo de la movilidad profesional y apoye la toma de decisiones”.

En línea con lo anterior, en el 2023, el Consejo Directivo de la OPS aprueba la *Política sobre el personal de salud 2030: fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes* (5), mediante la cual se plantea el desarrollo de acciones tendientes a recuperar los logros de salud pública afectados en razón de la pandemia por COVID-19 y continuar los esfuerzos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. La primera línea de acción estratégica llama a los Estados Miembros a fortalecer la gobernanza e impulsar políticas y planes nacionales de recursos humanos para la salud, mediante acuerdos intersectoriales que consoliden la rectoría de la autoridad de salud y fortalezcan la planificación y la previsión de los recursos humanos para la salud (RHS), el desarrollo de sistemas de información sobre RHS y la educación basada en el empleo de la ciencia, la evidencia y la innovación.

Uno de los principales desafíos identificados a la hora de construir información oportuna para la medición de RHS es que gran parte los sistemas de información para la salud (SIS), así como los pertenecientes a otras áreas del Estado, se han centrado en el desarrollo de soluciones aisladas en detrimento de una estrategia de gobernanza basada en la convergencia de acciones, la construcción de estándares y la búsqueda de una arquitectura de interoperabilidad de bases de datos que facilite el acceso a información pertinente y confiable. Asimismo, suelen existir retos inherentes a las políticas de acceso abierto a los datos capaces de facilitar la divulgación y el intercambio de datos e investigaciones.

Este documento propone la realización de un mapeo de actores de registros administrativos (RRAA) de RHS como punto de partida para la utilización de dichos registros con fines estadísticos que permitan avanzar hacia la consolidación de sistema de información de recursos humanos para la salud (SIRHS). La metodología de mapeo de actores tiene como objetivo identificar y trazar una hoja de ruta de trabajo conjunto entre los diferentes responsables de datos e información en el ámbito de los RHS, mediante el diálogo estratégico, la identificación de puntos de interoperabilidad y el establecimiento de acuerdos de colaboración entre estos actores. De este modo, se propicia una caracterización o representación visual de las personas, grupos, instituciones u organizaciones que se nuclea en torno a, o intervienen en, un asunto, un territorio o un problema determinado.

La riqueza de este tipo de aproximación radica en que no solo conforma un listado de actores, sino que registra sus relaciones, acciones, intereses, posibilidades y expectativas respecto de un tema de relevancia. En este sentido, este enfoque considera que la sociedad puede entenderse como una estructura que se manifiesta a través de diversas relaciones entre actores, definidos por sus valores, creencias y comportamientos, y organizados en redes compuestas por conjuntos de vínculos o relaciones sociales (6).

Utilizamos la perspectiva del mapeo de actores en lugar de la de decisores (*stakeholders*) debido a que, en la primera, el énfasis está puesto en explorar las conexiones y relaciones entre los actores y, al mismo tiempo, su vinculación con un tema o proyecto determinado. Por el contrario, la noción de decisores se centra en identificar las capacidades de los individuos o grupos para incidir en proyectos o políticas (7).

La utilización de RRAA con fines estadísticos está basada en la propuesta de Anders Wallgren y Britt Wallgren (8, 9). No obstante, al contar con pocos antecedentes acerca del mapeo de actores de RRAA para RHS en particular, la metodología aquí propuesta constituye un desarrollo propio e innovador, pensado específicamente para este trabajo.

Dimensiones relevantes de recursos humanos para la salud

Avanzar en el fortalecimiento de la información sobre los RHS implica considerar una serie de elementos, y para esto resulta necesario: *i)* establecer consensos sobre qué medir, *ii)* promover el uso de múltiples fuentes de información, *iii)* mejorar la comparabilidad, y *iv)* desarrollar herramientas y capacidad (10).

Resulta casi evidente que la información para la toma de decisiones —en salud o en cualquier otro ámbito— debe partir, en primera instancia, de la identificación de problemas concretos por resolver y de los consensos sobre las metodologías y criterios para medir dichos problemas. A partir de estos problemas, se definen las dimensiones y se construye el fenómeno por relevar, analizar y, eventualmente, predecir.

El punto de partida para el fortalecimiento de un SIRHS se ubica en la definición de lo que se va a considerar como personal de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a este como “toda persona que lleva a cabo tareas que tienen por principal finalidad promover la salud”. Ahora bien, como establece el *Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud* de la OMS, “un sistema de clasificación que solo tenga en cuenta las acciones de los individuos [formaciones, habilitaciones del personal de salud], o solo las de los lugares de trabajo [contratos laborales], probablemente no dará razón de todos los integrantes de la fuerza laboral sanitaria” (10).

Por tanto, se consideran dimensiones relevantes para el estudio de la fuerza de trabajo en salud la integración de los elementos de formación, la ocupación actual y el sector de actividad.

- **Formación:** se refiere al proceso educativo (formal e informal) que los individuos emprenden para adquirir las habilidades necesarias para desempeñarse de manera competente en un puesto de trabajo.

- **Ocupación:** se refiere a las tareas y funciones que las personas realizan en un trabajo.
- **Sector de actividad:** hace referencia a las actividades de los establecimientos o empresas donde las personas trabajan.

Esquemáticamente, el universo del personal de salud puede dividirse como se muestra en el cuadro 1.

CUADRO 1 Personal de salud según categoría, área de formación y sector de actividad

A	Trabajadores con formación sanitaria que trabajan en el sector de servicios de salud.
B	Trabajadores con formación en un ámbito no sanitario o sin formación académica que trabajan en el sector de servicios de salud.
C	Trabajadores con formación sanitaria que trabajan en un sector de actividad no relacionado con la atención de salud o que actualmente están desempleados o inactivos.

Fuente: adaptado de Dal Poz MRD, Gupta N, Quain E, Soucat AL (eds.). Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud, con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos [Internet]. Ginebra: OMS; 2009. Disponible en: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/d29c0539-f495-4200-8a01-570df61a12e4/content>.

Las categorías A y C representan, conjuntamente, al personal con formación en salud disponible en una región, mientras que A y B representan al personal que trabaja en el sector de la salud. La suma de las tres equivale al personal de salud total potencialmente disponible.

En el caso de los profesionales, debe destacarse que a la hora de identificar fuentes de información para la gestión de RHS no solo es relevante considerar las dimensiones antes enunciadas, sino también contar con fuentes que permitan identificar el nivel de actividad de dichos profesionales. Esto incluye distinguir entre aquellos habilitados para ejercer, los laboralmente activos y, dentro de estos últimos, los que efectivamente se encuentran prestando servicios en establecimientos de salud (2) (figura 1). Esta clasificación es esencial para obtener un panorama claro sobre la disponibilidad real de recursos y su distribución en el sistema de salud.

FIGURA 1 Niveles de actividad del personal de salud según las cuentas nacionales del personal de salud



Fuente: elaboración propia, con base en Eurostat. Health Care Resources [Internet]. Luxemburgo: Eurostat; 2022. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_res_esms.htm.

Por todo lo anterior, la consolidación de un sistema de información que considere esta multiplicidad de dimensiones debe valerse de múltiples fuentes de datos. En este sentido, es importante señalar que el desafío de integrar distintas fuentes involucra la construcción de una metodología capaz de manejar las discrepancias entre ellas. La recolección de datos suele mostrar diferencias entre categorías, definiciones de unidades de medida, periodicidades de las actualizaciones, identificación de las personas, entre otras. Esta necesidad de integrar datos extensivos, exhaustivos, actualizados y comparables implica una constante revisión y mejora de los procesos de recolección, análisis y producción de información.

La importancia de la gobernanza: ¿por qué un mapeo de actores?

Fuentes de datos: censos, encuestas y registros administrativos

Tradicionalmente, los Estados han contado con dos herramientas para poder relevar y consolidar información estadística a nivel sociodemográfico y ocupacional: los censos y las encuestas. Estas dos herramientas apuntan a lo que puede denominarse “producción estadística de datos primarios” y hacen uso de procedimientos e instrumentos de recolección de información (como formularios o cuestionarios) basados en objetivos estadísticos y en fundamentos conceptuales y metodológicos explícitos. A grandes rasgos, sus etapas son: la formulación conceptual, metodológica y operativa del problema por medir; el diseño del instrumento de recolección; la captación de los datos; el control de calidad; el ingreso y procesamiento informático de los datos; la evaluación de resultados; el análisis e interpretación de la información, y su difusión (11).

Sin embargo, existen también otras fuentes que están siendo progresivamente incorporadas por los organismos de estadística de los gobiernos debido a su relativo bajo costo, su cobertura sobre datos secundarios, y su accesibilidad y periodicidad de actualización, entre otros. Se trata de los registros administrativos (RRAA).

A continuación, se mencionan brevemente las ventajas y las limitaciones de estas herramientas de recolección de datos a la hora de acceder a información pertinente para el análisis de recursos humanos para la salud (RHS).

Censos

Un censo es el recuento de todos los individuos que conforman una población estadística. Los censos de población se realizan en los países con una periodicidad de 10 años, de acuerdo con las recomendaciones internacionales. La ventaja que ofrecen para el mapeo de los RHS es que brindan información precisa sobre el personal de salud, su composición, su distribución geográfica y sus características sociodemográficas. Además, al tratarse de un estudio sobre todo el abanico poblacional, no se ven afectados por el tamaño de las muestras al momento de planificar estimaciones para subgrupos más pequeños, como sucede con las encuestas.

No obstante, el aprovechamiento de los datos censales para el análisis de los RHS requiere un trabajo previo de incorporación de variables claramente definidas y clasificadas, para el cual es imprescindible la colaboración entre distintos organismos, como el Ministerio de Salud (MS), la oficina encargada del censo y otros actores interesados en el desarrollo de una estrategia de recopilación, análisis y utilización de esos datos (10).

Encuestas

Las encuestas por muestreo son otras de las posibles herramientas para la recopilación de datos de RHS que se suelen utilizar. Esta técnica estadística está basada en la obtención de datos representativos de la población a partir de la recopilación de información que ofrece un grupo seleccionado de ella. El primer paso para la realización de

una encuesta por muestreo es definir la población y los parámetros poblacionales que se busca estimar. Tanto los censos como las encuestas están basados en objetivos estadísticos y fundamentos conceptuales y metodológicos que se explicitan con anterioridad a la construcción del procedimiento y de los instrumentos para la recolección de la información deseada (8, 9, 12).

Es importante considerar que la realidad de cada país varía de acuerdo con su posibilidad de acceso a los recursos para la realización de encuestas periódicas y con su capacidad técnica para llevarlas adelante. Esta situación puede afectar la viabilidad a la hora de implementar encuestas a gran escala mediante el muestreo a nivel regional.

Registros administrativos

Los RRAA pueden definirse como aquellos procesos de captación permanente o sistemática de información sobre hechos, personas o acciones que se encuentran bajo regulación de algún organismo público. Estos registros son actualizados permanentemente debido a que están asociados a procedimientos administrativos que requieren sistematizar esa información (12).

Si bien en los distintos países resulta cada vez más extendida la utilización de estos registros con fines estadísticos, es preciso establecer algunas consideraciones. En primer lugar, se debe garantizar que la oficina nacional de estadística tenga acceso a los registros de los organismos que los gestionan, siempre atendiendo a la protección de datos personales. En segunda instancia, es preciso considerar los procedimientos necesarios para transformar estos RRAA en estadísticos, cuestión que usualmente implica la consolidación de un sistema de información que asegure que los datos puedan ser integrados y utilizados con eficacia. Finalmente, es importante velar por la consistencia en poblaciones y variables si el objetivo es realizar estimaciones estadísticas a partir de los mencionados registros (8).

Los RRAA como fuente de información estadística ofrecen varias ventajas: amplia cobertura, continuidad en la captación, desagregación geográfica, caracterización de los fenómenos a partir de las variables captadas, posibilidad de ampliar la cobertura conceptual y un bajo costo al aprovechar estadísticamente la información disponible (11).

Al mismo tiempo, presentan limitaciones y dificultades: los organismos responsables no los realizan con fines estadísticos ni cuentan con presupuesto asignado para este propósito; suelen tener una capacidad técnica limitada para sostener las funciones estadísticas con la calidad requerida; puede existir desinterés por parte de autoridades respecto de la finalidad estadística del registro; dificultades para la captación del fenómeno y para el control de las circunstancias en que se lleva adelante; ausencia de un soporte documental que respalde la conformación y sistematización metodológica del registro, y cambios en la estructura del registro por la omisión o agregado de variables.

El uso de RRAA para el análisis de los RHS resulta efectivo para realizar un monitoreo de la dinámica de los trabajadores y las trabajadoras de la salud (10). La recopilación continua de información permite a los organismos interesados planificar y gestionar la fuerza de trabajo en salud (FTS). En este sentido, la autoridad de salud a nivel nacional, así como los consejos y asociaciones profesionales, pueden aprovechar estos registros con dichos fines.

A medida que estos registros se utilizan y perfeccionan progresivamente, es posible consolidar un sistema de información que almacene, agrupe e integre el conjunto o serie de datos que proporcionan. En este marco, entendemos un sistema de información como un productor de datos secundarios que centraliza datos producidos por otros organismos, áreas o jurisdicciones del Estado.

Si bien actualmente los avances en materia de tecnología informática han hecho más factible, confiable y menos costosa la vinculación entre las distintas bases de datos administrativas, la utilidad de un sistema de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) no depende principalmente de este factor, sino de su capacidad de adaptarse para atender a la problemática de recursos humanos vigente y generar información exacta y puntual (10).

La importancia de la gobernanza

La consolidación de un SIRHS implica atender, como eje central, el problema de la gobernanza. El abordaje de los principales desafíos de la FTS —como la escasez numérica, el desarrollo de competencias o los desequilibrios en la distribución— requiere un enfoque de gobernanza estratégico centrado en la coordinación y la implementación de políticas orientadas a mejorar el desempeño del personal (13). En este sentido, contar con un adecuado diagnóstico acerca de la situación de la fuerza de trabajo resulta fundamental para atender los problemas de salud.

Para arribar a ese diagnóstico, el objetivo último del proceso apunta a construir un sistema de información que garantice la integración de datos de manera eficiente y orientada a su aprovechamiento estadístico. Esto implica abordar la dispersión de los RRAA que fueron creados con fines de gestión y no estadísticos. En este sentido, es necesario garantizar la capacidad de tomar definiciones acerca de los registros y su vinculación; entablar alianzas y mecanismos sostenibles de intercambio de datos, información, conocimiento, inversión y financiamiento, e impulsar la implementación de sistemas de información y salud digital interoperables, abiertos y sostenibles.

El primer paso para avanzar en la gobernanza de un SIRHS es identificar una estructura organizacional de gestión de RHS que lidere el proceso, que pertenezca al ámbito del MS del país, y que tenga la responsabilidad y la capacidad de articular y coordinar las funciones básicas de políticas, planificación y gobernanza de RHS, así como la gestión de sus datos. Idealmente, esta **Unidad Estratégica de RHS** debe cumplir los siguientes requisitos:

- Reunir o construir las herramientas legales y normativas para diseñar y hacer cumplir los lineamientos propuestos.
- Implementar mecanismos de concertación permanentes y sostenibles.

En este sentido, no se trata únicamente de reunir las capacidades técnicas, sino, sobre todo, de contar con la capacidad política para coordinar los esfuerzos entre diversos sectores y niveles de gobierno. Algunos países han avanzado en la creación de estructuras políticas intersectoriales u otras instancias colegiadas de alto nivel para el abordaje de las políticas de RHS. Estos ámbitos constituyen el espacio por excelencia para liderar la gobernanza de este proceso. En los casos donde no existan, esta metodología, conducida desde el MS, puede inducir su constitución progresiva.

Las islas de datos

El principal desafío identificado a la hora de construir información oportuna para la medición de RHS es que gran parte de los sistemas de información para la salud (SIS), así como los pertenecientes a otras áreas del Estado, se han centrado en el desarrollo de soluciones tecnológicas aisladas, en detrimento de una estrategia de gobernanza que propicie la convergencia de acciones y la interoperabilidad de bases de datos para facilitar el acceso a información pertinente y confiable. Construir una arquitectura de interoperabilidad e intercambio de información escalable requiere un rol central de la autoridad de salud, que facilite la comunicación entre los diferentes niveles de gobierno y los subsistemas de salud (1).

Esta necesidad adquiere relevancia ante el progresivo avance tecnológico y la implementación de la salud digital (que introdujo herramientas como la historia clínica electrónica, la telesalud, entre otras). Se espera que los documentos clínicos electrónicos incluyan referencias a componentes del sistema de salud —profesionales,

establecimientos, especialidades, financiadores—, lo que torna necesario el uso de vocabularios comunes comprensibles para todos los participantes del proceso. A esto se lo denomina **interoperabilidad semántica** (14).

La **interoperabilidad semántica** se refiere a la capacidad de diferentes sistemas de información en salud para intercambiar datos, así como para interpretar y comprender su significado de manera coherente y uniforme. Va más allá de la simple transmisión de datos (dominio de la interoperabilidad sintáctica) y se adentra en la comprensión del contexto y el significado de esos datos. Mientras que la **interoperabilidad sintáctica** se enfoca en la compatibilidad de formatos y protocolos de comunicación, asegurando que los datos puedan ser intercambiados entre sistemas, la interoperabilidad semántica busca que estos datos sean interpretados y utilizados de manera consistente en diversos entornos, a fin de evitar malentendidos o confusiones sobre su significado.

Esta distinción es especialmente crucial en el campo de la salud, donde la misma terminología puede tener diferentes interpretaciones en contextos distintos. La interoperabilidad semántica, por lo tanto, no solo **facilita** la comprensión uniforme de términos y conceptos dentro de los sistemas de salud, sino que también **necesita** de la estandarización de procesos para garantizar una integración coherente y eficiente de la información.

Existen algunos aspectos de la interoperabilidad que no deben pasarse por alto. En primer lugar, es necesario incorporar este precepto en los planes y políticas nacionales vinculados con los sistemas de información, atendiendo a la gestión y gobernanza de los propios sistemas, de los datos y de las tecnologías de la información, así como a la gestión del conocimiento, la innovación y la integración y convergencia digital. En segundo lugar, se requiere consolidar una infraestructura de intercambio de datos abiertos e información crítica centrada en el respeto a criterios éticos y de ciberseguridad en los flujos de información. Finalmente, se recomienda definir los esquemas de gobernanza de los datos generados por la interoperabilidad de los sistemas de salud, con el objetivo de propiciar el uso secundario de la información para la toma de decisiones tácticas y operativas (15).

La gobernanza de datos constituye un eje central. Se trata de una disciplina de gestión orientada a facilitar a las organizaciones el control de sus datos y a mejorar su capacidad para generar información de calidad que respalde la toma de decisiones (16). En este sentido, remite al conjunto de prácticas organizadas en torno a la gestión de datos y a la toma de decisiones sobre su uso. El objetivo es optimizar la capacidad de utilización de esos datos de modo que ofrezcan información de calidad para la fundamentación de políticas, estrategias y la gestión operativa de, en este caso, los RHS.

La construcción y consolidación de una infraestructura para los SIS está ligada al reconocimiento de varios elementos:

1. Identificar quién es “propietario” de los datos, quién los utiliza y quién puede tomar decisiones acerca de estos.
2. Reconocer en qué lugar se almacenan los datos y cómo se organiza el acceso a estos.
3. Establecer mecanismos para garantizar su calidad e interoperabilidad.
4. Proteger los datos de amenazas como su accesibilidad o uso inapropiados.
5. Determinar las herramientas, recursos y destrezas que se necesitan para gestionar y utilizar los datos de manera eficaz.

Todas estas consideraciones implican la identificación de los actores clave involucrados en la consolidación de un SIRHS. Para ello, a continuación, se propone la metodología para el mapeo de actores.

Registros involucrados en el desarrollo de un sistema de información de recursos humanos para la salud

Para constituir un sistema de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) basado en registros administrativos (RRAA), un primer paso es identificar cuáles de esos registros son más relevantes.

Un sistema de información para la salud (SIS) (en términos generales, no solo respecto de los recursos humanos para la salud [RHS]) debe apuntar, en primera instancia, a reconocer, definir y conformar entidades a partir de registros que permitan la identificación unívoca de los tres pilares del sistema de salud: **usuarios, profesionales y establecimientos**. Estos registros se denominan **registros de referencia**.

Los registros de referencia deben surgir de normas que los jerarquicen e instituyan como estándares y que permitan su progresiva aplicación a lo largo de un territorio de manera sinérgica, con el fin de integrar el conjunto del sistema. En el proceso de la transición hacia la salud digital, se vuelve imperioso contar con estándares definidos, conocidos y compartidos, que permitan el intercambio de información de forma accesible, rápida y coherente con respecto a **quién brinda la atención (profesionales), dónde se brinda (establecimientos) y a quién se dirige (usuarios)**.

La gestión de los registros recae generalmente en las funciones del Ministerio de Salud (MS). Estos surgen como herramientas regulatorias que permiten a los MS ejercer competencias esenciales para el ordenamiento del sistema de salud. En algunos casos, la normativa indica la delegación de capacidades en otros actores por fuera del Estado —como consejos, colegios o asociaciones—, que generan RRAA útiles y necesarios para la consolidación de SIRHS. Entre estas funciones se incluyen la fiscalización y habilitación de establecimientos y, cuando la potestad no ha sido delegada, la garantía de la idoneidad de los profesionales que brindan atención de salud.

No obstante, cada país ejerce estas funciones en mayor o menor medida, lo que se traduce en distintos grados de implementación de los registros. Esto no debe interpretarse como una limitación, sino como una oportunidad para su fortalecimiento. La conformación de un SIRHS puede mejorar el ejercicio de la regulación del MS o partir del objetivo de impulsarlo.

La oportunidad para fortalecer la gobernanza puede alcanzar tanto al sector público como al sector privado, y permite liderar el proceso de transformación, así como proveer información de calidad para los encargados de la toma de decisiones.

A medida que estos registros se utilizan en diversos contextos y aplicaciones, se someten a un proceso de “estrés” que contribuye a su validación y mejora continua. Este uso intensivo permite perfeccionar la calidad de los datos,

corregir inconsistencias y actualizar la información de manera sistemática, fortaleciendo su valor para la toma de decisiones estratégicas en salud.

En el caso de los **registros de usuarios**, cabe aclarar que, si bien estos registros son herramientas muy útiles en los sistemas de información de salud y estrategias de salud digital, un modelo de SIRHS basado en la oferta no depende necesariamente de ellos. Aunque pueden utilizarse para validar datos del personal de salud y recuperar información relevante que permita enriquecer el análisis, estos registros suelen estar menos desarrollados, no se centran en los profesionales intervinientes y, en muchos casos, están sujetos a acuerdos de confidencialidad que limitan su accesibilidad para fines estadísticos o administrativos. En consecuencia, no profundizaremos en su análisis en este documento.

Asimismo, existen actores que, aunque no poseen RRAA, son esenciales para el intercambio de información. Se trata de áreas asociadas a funciones de apoyo imprescindibles para el desarrollo de procesos administrativos, como las de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), o asuntos jurídicos. Finalmente, pueden identificarse actores que se benefician administrativamente de los registros y, en este sentido, resultan estratégicos para lograr su actualización.

Registros de referencia

Habilitaciones profesionales y especialidades (Registro de Referencia de Profesionales)

En la mayoría de los países, los proveedores de atención de la salud calificados necesitan una autorización para ejercer su profesión. Este requisito da lugar a la conformación de RRAA cuya finalidad es garantizar que los profesionales cumplan con los requisitos legales para brindar servicios asistenciales, lo cual asegura la calidad y seguridad de la atención. Estos registros, gestionados por organismos de reglamentación profesional como MS, colegios o consejos profesionales, constituyen una valiosa fuente de información para el seguimiento del personal de salud.

Debido a que su propósito principal es garantizar la idoneidad y la responsabilidad legal en el ejercicio profesional, estos registros suelen contener información de alta calidad en lo referente a habilitaciones, especialidades y datos de identificación personal de los profesionales, como el número de identificación personal o el nombre completo, entre otros. Sin embargo, pueden presentar datos de menor calidad, o desactualizados en otros aspectos, como información sobre las instituciones de formación, domicilio de residencia o país de nacimiento.

Además, otra característica de estos registros es que generalmente reflejan con mayor precisión las altas de los nuevos profesionales que ingresan al sistema, pero pueden tener dificultades para reflejar las bajas de aquellos que dejan de ejercer, ya sea por jubilación, cambio de profesión o fallecimiento (17).

Establecimientos de trabajo (Registro de Referencia de Establecimientos)

La recopilación de datos de establecimientos de salud permite identificar al personal que se encuentra en actividad. La mayoría del personal de salud desempeña sus funciones en instituciones, a través de las cuales percibe su salario.

Se consideran establecimientos de salud los puntos de prestación de servicios del sector de la salud formal, como hospitales, centros de salud, dispensarios y puestos de salud (10).

Muchas veces, los registros de establecimientos compilan también información relativa a su dotación de personal. Es decir, pueden ofrecer información detallada sobre la disponibilidad, la distribución, las calificaciones, la

combinación de competencias, la formación y el desempeño del personal de salud. Dicha información es útil para comparar los patrones reales de dotación de personal con los niveles de dotación deseados o previstos, averiguar en qué medida las calificaciones de los trabajadores se corresponden con la descripción de su puesto de trabajo, y determinar la naturaleza y la magnitud de los desequilibrios —geográficos o de otro tipo— en la dotación de personal.

No obstante, muchas veces no se dispone de una lista exhaustiva y actualizada de todos los establecimientos y su dotación de personal georreferenciados, como tampoco se cuenta con categorías comunes y clasificadores que vuelvan comparable la información, incluso entre los diferentes subsectores de salud de un mismo país (público, privado y de la seguridad social).

Registros auxiliares

Una vez definidos los **registros de referencia** para la definición del universo de profesionales y establecimientos dentro del país, es importante identificar y utilizar una serie de fuentes de datos adicionales que puedan **estandarizar y enriquecer** la información relativa a los RHS. Estos registros, denominados **registros auxiliares para la conformación de un SIRHS**, son fundamentales para consolidar un sistema que integre eficazmente la información disponible y mejore la calidad y completitud de los datos, apuntando a la automatización de procesos.

La integración de los registros auxiliares permite lo siguiente:

- **Validar y actualizar información:** corroborar datos existentes y actualizar información obsoleta o incompleta.
- **Estandarizar datos:** aplicar clasificaciones y codificaciones uniformes para facilitar el análisis y la comparabilidad.
- **Enriquecer la información:** incorporar nuevos datos que aporten valor añadido al análisis de los RHS.

Este proceso requiere la vinculación de diferentes registros para la depuración y validación de la información, especialmente si lo que se persigue es la estimación de la disponibilidad y el estado de actividad de los profesionales de la salud. Por ejemplo, en los registros de profesionales puede resultar complejo registrar la baja de la práctica asistencial cuando la permanencia en el registro no implica un costo periódico para el profesional. En tales casos, es necesario validar y complementar la información con otros registros generales, como los de identificación de personas, migraciones o agencias tributarias.

Para la planificación y conformación de un SIRHS, estos datos son muy relevantes, ya que permiten analizar dimensiones tales como la distribución geográfica, sectorial y ocupacional de los RHS. La dificultad radica en que la baja estandarización y heterogeneidad de los datos requiere un intenso trabajo de gestión y preparación de datos (*data wrangling*), que incluye la manipulación, limpieza, mejoramiento y validación de la información.

Por lo anterior, resulta necesario implementar técnicas avanzadas de integración y vinculación de datos (*data linkage*), que permitan identificar y enlazar registros correspondientes a la misma entidad a través de diferentes conjuntos de datos. El objetivo final es obtener diccionarios de equivalencias y desarrollar esquemas de codificación estandarizados que armonicen la información y faciliten su comparabilidad. Este proceso es iterativo y gradual, y puede requerir la modificación de los sistemas preexistentes a fin de adoptar codificaciones y estándares más alineados con las prácticas estadísticas internacionales, como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).

Para una integración efectiva de los registros auxiliares es fundamental, mediante el mapeo de actores, identificar las fuentes de datos disponibles, evitar la duplicación de esfuerzos y establecer colaboraciones con las instituciones responsables de su gestión.

Nóminas de personal del subsector público

Los registros de personal son una herramienta esencial para la identificación y el análisis de la dotación de personal activo en un país y su distribución por efector de salud. A diferencia de los registros de profesionales, que pueden tender a sobreestimar el personal de salud debido a una insuficiente depuración de datos históricos, los registros de nómina o contratos de personal se actualizan al menos mensualmente para la liquidación de haberes.

Por lo tanto, si bien los registros de referencia de profesionales y establecimientos constituyen los pilares fundamentales del sistema de información, sobre los cuales se estructura su capacidad analítica y operativa, se debe atender también la complejidad inherente a los registros de contratos de personal de salud, a los que se denomina **planteles**. Esta complejidad se deriva de su heterogeneidad, diversidad sectorial y multiplicidad de fuentes, lo que exige un esfuerzo adicional en su estandarización e integración.

Estos registros contienen información detallada sobre las características laborales de los empleados, como sus cargos, funciones, salarios, antigüedad o condiciones de contratación. Además, permiten el monitoreo de aspectos como incorporaciones de personal, rotaciones y licencias.

Por otra parte, los registros permiten obtener una visión detallada y oportuna del personal que efectivamente está desempeñando funciones en el ámbito de la salud. En términos de las cuentas nacionales del personal de salud, estos registros permiten determinar no solo el personal activo (*professionally active*), sino en especial aquel que se encuentra prestando efectivamente servicios de salud (*practising*).

Todas las instituciones —públicas, privadas, de seguridad social— cuentan con registros de nómina para la gestión de su personal. Sin embargo, un SIRHS que aspire a capturar la totalidad del personal se enfrentará a diversas dificultades, comenzando por la cantidad y heterogeneidad de entidades que contratan personal, así como por las restricciones de privacidad y accesibilidad a este tipo de información.

Debido a que los MS suelen ser importantes empleadores a nivel nacional o subnacional, sus registros de personal representan un buen punto de partida para la identificación y la recolección de datos de RHS en el subsector público.

Uno de los principales desafíos en la utilización de este tipo de registros es su bajo nivel de estandarización de las variables. Con frecuencia, contienen datos confiables en lo relativo a la liquidación de haberes —como número de identificación personal, nombre y apellido, tipo de contrato, salario y horas trabajadas—, pero las variables que no están directamente relacionadas con aspectos financieros suelen presentar inconsistencias. Estas se deben tanto a la baja estandarización de los campos —es decir, la falta de implementación de catálogos de datos— como a la utilización de clasificaciones asociadas a la gestión administrativa que requieren procesos de recodificación antes de poder ser utilizadas para el estudio y la planificación de RHS.

Por ejemplo, es común que, en términos de dotaciones, los trabajadores aparezcan en nómina asignados a reparticiones administrativas o gerenciales cuando en la práctica desempeñan funciones en establecimientos asistenciales, o a la inversa. Incluso cuando se identifica correctamente al personal en las reparticiones asistenciales, los establecimientos pueden no coincidir con el registro oficial de establecimientos del país (registro de referencia), lo que dificulta evaluar el tipo de efector, nivel de atención, etcétera. Tampoco la información relacionada con titulaciones o profesiones del personal de salud suele estar clasificada de forma homogénea o con niveles de desagregación suficientes para la planificación de RHS. Generalmente, su segmentación obedece más a los escalafones existentes para el pago que a categorías ocupacionales o profesionales.

Para superar estos desafíos y enriquecer la información, es importante realizar un trabajo de modelización de los datos y efectuar cruces con los registros de profesionales y establecimientos. La implementación de catálogos de datos estandarizados contribuye a mejorar la calidad y usabilidad de los registros de nómina.

La complejidad de utilizar estos registros como insumo para obtener información del sector público variará según se trate de países unitarios o federales, y según el nivel de autonomía municipal en la contratación de personal de salud.

En el caso del sector privado, si bien acceder a estos registros puede ser dificultoso, en algunas ocasiones existen organismos descentralizados de los MS, como las superintendencias, que ejercen funciones de fiscalización de las entidades privadas y del cumplimiento de regulaciones vigentes en materia sanitaria, laboral y tributaria. Estos organismos suelen realizar procesos de habilitación o acreditación, y pueden contar con información sobre planteles del sector privado o de la seguridad social, recolectada según sus necesidades regulatorias específicas.

Otra vía para acceder a estos registros puede ser la articulación con las agencias tributarias de cada país, como se verá más adelante.

Validación de identidad de las personas

Las fuentes de información relacionadas con la validación de la identidad de las personas suelen ser gestionadas por oficinas de registro civil, policías nacionales o entidades gubernamentales similares, siempre a nivel nacional. Incluyen registros de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros, que constituyen la base legal para la identificación oficial de individuos. A través de estos registros se emiten documentos de identidad fundamentales como la cédula, el documento único (DU), el rol único nacional (RUN), el documento nacional de identidad (DNI), el registro de personas físicas (CPF, por su sigla en portugués). Estas instituciones proporcionan datos utilizados por otras entidades públicas y privadas para verificar la identidad de las personas y asegurar su correspondencia en trámites legales, financieros y sociales (18).

Titulaciones (pregrado, grado y posgrado)

Las instituciones educativas como escuelas y universidades expiden titulaciones académicas mediante mecanismos específicos, que implican el reconocimiento de su validez. Generalmente, dicho trámite administrativo suele realizarse en registros bajo la órbita de los ministerios de Educación (a nivel nacional o subnacional). Estos registros suelen incluir datos sobre estudiantes, programas académicos, títulos obtenidos y certificaciones profesionales en niveles de pregrado, grado y posgrado (19). Permiten construir indicadores relevantes para RHS, como cantidad de ingresantes, alumnos y egresados por año y por carrera, relación con el personal de salud activo, entre otros.

Información tributaria (personas físicas y jurídicas)

Las fuentes de información tributaria (de personas físicas y jurídicas) se utilizan para el análisis de la dinámica del mercado laboral y la comprensión de las relaciones entre empleadores y empleados en diversos sectores.

Existen diferentes tipos de datos tributarios administrativos que se recopilan con el fin de gestionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estos datos incluyen registros de contribuyentes, declaraciones autoevaluadas, declaraciones informativas y de retenciones, datos aduaneros, así como registros de procesos internos y recursos humanos de las autoridades tributarias.

La disponibilidad y la accesibilidad de estos datos varían según el país; no obstante, en general permiten una visión integral del comportamiento fiscal de las personas físicas y jurídicas (20).

Información de migración de personas

Los RRAA en materia migratoria recopilan datos sobre los hechos y eventos que experimenta cada individuo al desplazarse entre países. Estos registros incluyen características demográficas, migratorias y socioeconómicas, entre otras, de toda la población o de una parte de ella. En términos de medición de la migración internacional, este tipo de fuente de datos generalmente abarca registros de llegadas y salidas internacionales, población extranjera, permisos para trabajadores migrantes, solicitudes de asilo, permisos de residencia, estudio o trabajo, otorgamiento de solicitudes, registros consulares de nacionales en el extranjero, así como otros documentos vinculados, como visas y pasaportes (21).

Las denominaciones de las áreas a cargo varían en la Región, pero suelen estar asociadas con entidades de gobierno que gestionan la seguridad interna, las relaciones exteriores o áreas específicas de migración.

Pensiones y jubilaciones

Los registros de pensiones y jubilaciones son sistemas administrativos que recopilan información sobre las transiciones laborales del personal de salud hacia el retiro. Estos registros documentan diversos tipos de salidas del mercado laboral, incluyendo jubilaciones ordinarias y anticipadas, pensiones por invalidez, beneficios por enfermedad profesional y retiros voluntarios, junto con datos demográficos, laborales y previsionales del personal de salud.

La gestión de estos registros recae en diversas instituciones según el país, entre ellas, los sistemas de seguridad social, ministerios de Trabajo, cajas de jubilaciones profesionales, administradoras de fondos de pensiones y superintendencias previsionales. Esta diversidad institucional refleja la complejidad de los sistemas previsionales y hace necesaria una coordinación intersectorial que permita obtener una visión integral de las salidas de la fuerza de trabajo en salud.

Metodología para el mapeo de actores y diálogo estratégico

La metodología del mapeo de actores y diálogo estratégico de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) que se propone tiene como objetivo elaborar un listado de los actores involucrados en ese ámbito; registrar sus relaciones, acciones, intereses, posibilidades y expectativas al respecto, e involucrarlos en un proceso colaborativo estratégico hacia un SIRHS integrado.

El impulso para generar y poner en marcha un SIRHS exige un sólido aval político del más alto nivel de la autoridad sanitaria. Esa voluntad política puede inclusive colocarse en el seno de instancias colegiadas que resaltan la importancia del tema y facilitan un proceso con mayores opciones de participación e institucionalización.

Objetivos

1. Identificar las áreas de gestión del Ministerio de Salud (MS) y de otros organismos que poseen registros administrativos (RRAA) que pueden ser utilizados para construir datos sobre recursos humanos para la salud (RHS).
2. Generar las acciones político-normativas, administrativas y tecnológicas identificadas como necesarias para el fortalecimiento de la gobernanza en materia de construcción y gestión de datos sobre RHS.

Etapas

1. Identificación del área encargada de liderar el proceso de mapeo de actores y diálogo estratégico.
2. Caracterización del contexto de salud del país, sus metas en términos de políticas sanitarias y el marco estratégico en el que se propone el desarrollo de un SIRHS.
3. Reconocimiento de la estructura político-administrativa del país y de su modelo de atención de la salud (sector público, privado y de seguridad social; grado de descentralización en la gestión y financiamiento), así como de las áreas que gestionan registros relacionados a RHS.
4. Identificación de las características, la normativa y los convenios asociados a los registros de referencia y auxiliares, incluyendo su objetivo, alcances y actualización.
5. Identificación de actores interesados en información de RHS para diversos fines, como la planificación estratégica, la elaboración de estadísticas, la gestión de procesos administrativos o el desarrollo de la salud digital, así como las vinculaciones que mantienen entre sí.
6. Conformación de una mesa de trabajo que reúna a las áreas participantes del proceso de construcción y gestión de los datos relativos a RHS, y elaboración de la hoja de ruta del proceso.

Equipo para la conformación de un sistema de información de recursos humanos para la salud

El punto de partida para realizar un mapeo de actores para un SIRHS basado en los RRAA de RHS es la identificación del área que debería liderar la iniciativa, idealmente aquella instancia de gobierno que utilizará estratégicamente los datos para la planificación de los RHS.

Es importante, al momento de conceptualizar el equipo de trabajo para la operación del sistema, registrar todos los nodos que brindarán su aporte, considerando la estructura nacional y subnacional de la salud, así como las instituciones que participarán, tanto en su función de recopilación de información como, sobre todo, en el uso de la información para la toma de decisiones.

De ahí que el equipo no deba reducirse únicamente a un grupo central de profesionales, sino que implique una red de contactos. Esto, además de garantizar una recopilación de información abarcativa, permite generar una red de acción que es un factor clave para la sostenibilidad del sistema.

No obstante, se requiere de un equipo coordinador. La responsabilidad del ejercicio de mapeo corresponderá al área que posea competencias en materia de gestión y planificación de RHS, habitualmente perteneciente al MS a nivel nacional.

Se recomienda conformar un equipo coordinador integrado por representantes de diferentes áreas del MS (con perfiles de planificación, salud pública, gestión de servicios y tecnologías). En general, este equipo tiene la responsabilidad de liderar el proceso técnico para identificar las fuentes de información, realizar el análisis de la situación base y coordinar el trabajo de los diferentes agentes implicados. Asimismo, es necesario contar con el soporte del personal de informática encargado de la gestión bases de datos, que permitirá evaluar la posible integración de la información (cuadro 2).

CUADRO 2 Conformación del equipo coordinador

Descripción	Perfil	Principales tareas
Líder de proyecto	Formación universitaria en ciencias sociales o de la salud, sistemas de información o derecho. Experiencia general en gestión de proyectos, incluyendo articulación intersectorial, y experiencia específica en sistemas de información o políticas públicas sanitarias.	Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, coordinar el equipo, articular con los distintos perfiles y supervisar el marco normativo aplicable.
Analista funcional	Formación universitaria en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Experiencia en infraestructura tecnológica y gestión de procesos en salud.	Identificar y analizar sistemas de información, bases de datos e infraestructura. Proponer estrategias de mejora.
Analista de datos	Formación universitaria completa o comprobable en áreas analíticas (ciencia de datos, estadísticas, informática, matemática, etc.).	Extraer, procesar y analizar datos estadísticos. Proponer mejoras basadas en datos y dar seguimiento a las soluciones implementadas.
Asesor jurídico	Formación universitaria en derecho, con experiencia en derecho administrativo, normativa de salud (deseable) y gestión de convenios interinstitucionales.	Identificar la normativa vigente aplicable a registros y datos, proponer acuerdos para el intercambio de información, y asegurar el cumplimiento legal y ético del proyecto.

Propuesta de matriz de relevamiento de actores de recursos humanos para la salud

Para orientar el ejercicio de mapeo de actores relevantes para la conformación de un SIRHS, se propone la elaboración de una matriz de relevamiento (véase el anexo 3). Esta matriz permitirá esquematizar y organizar a los actores clave según el grado de rectoría o influencia que el MS tiene sobre ellos. Actuará como una hoja de ruta para establecer los dispositivos de gobernanza necesarios para la construcción y gestión de datos sobre RHS.

Los actores se clasificarán en diferentes categorías —decisores, liderazgo y coordinación del SIRHS, soporte legal y tecnológico, proveedores de información y usuarios de datos— y se organizarán en función de su grado de cercanía al MS. La organización comenzará con los actores sobre los cuales el MS ejerce un mayor control o con los que mantiene una relación directa, y se extenderá hacia aquellos con menor grado de rectoría. Para esto, se propone una división sectorial entre Estado (nacional/subnacional), sector privado y sociedad civil. La especificidad del sector de la seguridad social se analizará más adelante (véase el recuadro 1).

- **Decisores:** son las autoridades y organismos que tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas, establecer políticas y asignar recursos en relación con el SIRHS. Son los responsables de definir las directrices generales, prioridades y objetivos del proyecto, e impulsan la articulación con otros organismos.
- **Liderazgo y coordinación del SIRHS:** esta categoría incluye a las unidades y áreas encargadas de **liderar y coordinar** la implementación y operación del SIRHS.
- **Soporte legal y tecnológico:** abarca a las áreas y entidades que proporcionan el **soporte legal y tecnológico** necesario para la integración administrativa y tecnológica de un SIRHS. Incluye tanto el marco normativo y regulatorio como la infraestructura tecnológica, el desarrollo de soluciones interoperables y el soporte técnico.
- **Proveedores de información (registros de referencia):** refiere a las entidades que tienen bajo su órbita la gestión registral de información estructural de los servicios de salud.
- **Proveedores de información (registros auxiliares):** incluye a las entidades poseedoras de **registros y datos adicionales** que pueden enriquecer y validar la información del SIRHS.
- **Usuarios de datos:** son las entidades y actores que **utilizan la información** proporcionada por el SIRHS para diversos fines, como la planificación, la toma de decisiones, la investigación, la gestión y la mejora de los servicios de salud.

Las categorías son indicativas pero no excluyentes, pues los nodos que producen los datos pueden ser los mismos que lideran y deciden. Es decir que la combinación de funciones y su ejercicio simultáneo son posibles.

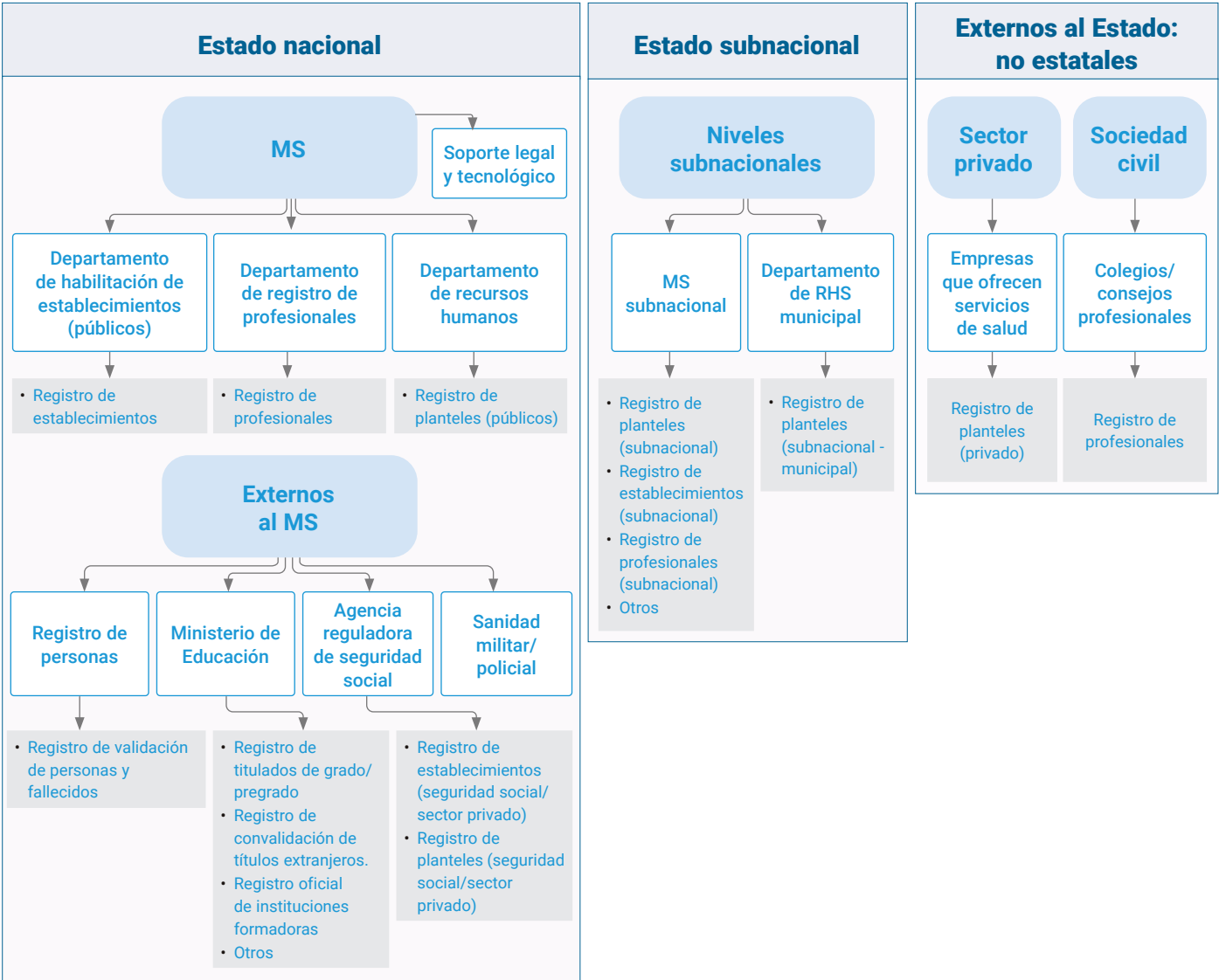
RECUADRO 1 EL SECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ROL DE LOS ORGANISMOS REGULADORES

Los **organismos reguladores de la seguridad social**, como las superintendencias de salud, supervisan y regulan la calidad de los servicios de salud provistos en el marco de la seguridad social. Su función incluye la fiscalización de prestadores y aseguradoras, la protección de derechos de los afiliados y el monitoreo del uso de recursos. De este modo, actúan como un punto de conexión entre el sector público y el privado en la prestación de servicios de salud.

En la matriz propuesta a modo de ejemplo (véase el anexo 3), hemos considerado a estos organismos como actores del **Estado**. Sin embargo, su estructura y competencias varían significativamente entre países, en función del modelo de gobernanza en salud y la organización del sistema de seguridad social. En algunos contextos, operan bajo la rectoría directa del Ministerio de Salud, mientras que en otros tienen mayor autonomía. Por lo tanto, será necesario **readecuar la matriz** de acuerdo con la realidad de cada país, ajustando su ubicación y su rol según su nivel de integración y vinculación con el sistema de salud nacional.

Una vez elaborada la matriz de relevamiento, se propone que, a partir de la información recopilada, se confeccionen diagramas que permitan visualizar de manera clara las áreas esenciales para la conformación de un SIRHS (figura 2). Se sugiere optar por la utilización de flujogramas que resuman las relaciones entre las áreas y su grado de cercanía respecto del MS. Estos diagramas facilitarán la comprensión de las interacciones y la estructura de gobernanza.

FIGURA 2 Ejemplo de diagrama de mapeo de actores



MS: Ministerio de Salud; RHS: recursos humanos para la salud.

Debido a la multiplicidad de actores potencialmente involucrados, se recomienda elaborar distintos diagramas que permitan expresar las relaciones dentro del MS, entre el MS y otras entidades del Estado a nivel nacional y subnacional, y entre los organismos del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Estos diagramas facilitarán la comprensión de las interacciones específicas en cada ámbito y contribuirán a una mejor planificación y gestión en la conformación del SIRHS.

Guía operativa para el desarrollo del mapeo de actores

A continuación, se presenta una guía para el desarrollo del mapeo de actores de registros administrativos (RRAA) de recursos humanos para la salud (RHS) (véase el recuadro 2). Esta guía se propone como **hoja de ruta**, es decir, como una serie de pasos para el reconocimiento de los actores involucrados en dicho ámbito, así como sus acciones y relaciones. Debido a que la estructura político-administrativa, el modelo de atención de la salud, los recursos disponibles y la madurez de los registros difieren entre los distintos países de la Región, la aplicación de esta metodología deberá ser flexible y adecuarse a cada situación particular. La guía contempla el recorrido completo del proceso, pero cada país establecerá su punto de partida de acuerdo con sus avances y las relaciones estratégicas previamente establecidas en torno a los sistemas de recursos humanos para la salud (SIRHS).

RECUADRO 2 GUÍA OPERATIVA

1. Identificación del área encargada de liderar el proceso y aplicación de la guía de autoevaluación
2. Mapeo de actores
 - 2.1 Caracterización del contexto y el marco político estratégico
 - 2.2 Reconocimiento de la estructura político-administrativa del país
 - 2.3 Reconocimiento del modelo de atención de la salud
 - 2.4 Identificación de actores del MS pertinentes para el SIRHS
 - 2.4.1 Exploración del organigrama y funciones del MS
 - 2.4.2 Identificación de registros de referencia de salud
 - 2.4.2.1 Identificación de áreas encargadas de habilitaciones/idoneidades de profesionales
 - 2.4.2.2 Identificación de áreas encargadas de habilitaciones/acreditaciones de establecimientos
 - 2.4.3 Identificación de otros registros administrativos y de información, y de otros sistemas relevantes para RHS dentro del MS (registros auxiliares)^a
 - 2.5 Identificación de la infraestructura tecnológica dentro del MS
 - 2.6 Identificación de la normativa y convenios existentes sobre intercambio de datos dentro del MS
 - 2.7 Identificación de otros organismos con datos relevantes para la validación y enriquecimiento de los datos (registros auxiliares externos)
 - 2.7.1 Identificación de áreas encargadas de contratos de trabajo (registros de planteles)

- 2.7.2 Identificación de áreas encargadas de la validación de personas
- 2.7.3 Identificación de áreas encargadas de registros de titulaciones
- 2.7.4 Identificación de áreas encargadas de registros tributarios
- 2.7.5 Identificación de áreas encargadas de eventos migratorios
- 2.8 Confección de la matriz de relevamiento de actores
- 3. Relevamiento de datos de registros
 - 3.1 Preparación de entrevistas
 - 3.2 Entrevistas a actores
 - 3.3 Conformación de la matriz de relevamiento de registros
- 4. Concertación y formalización de acuerdos estratégicos
 - 4.1 Validación y ajuste de la matriz y el diagrama de actores
 - 4.2 Caracterización de registros recolectados y análisis de calidad de datos
 - 4.3 Construcción de consensos e instrumentación mediante convenios o acuerdos de gestión
 - 4.4 Priorización de actores, acciones clave y reconfiguración de la hoja de ruta

^a Véase el apartado "Registros auxiliares".

MS: Ministerio de Salud; RHS: recursos humanos para la salud; SIRHS: sistema de información de recursos humanos para la salud.

Autoevaluación y mapeo de actores

Guía de autoevaluación

La guía de autoevaluación (anexo 1) tiene como objetivo principal establecer una línea de base. A través de este primer paso, se busca definir claramente la información inicial, identificar a los actores clave ya involucrados en la gestión de datos y determinar las necesidades específicas de información sobre RHS.

Mapeo de actores

Caracterización del contexto político estratégico

Los SIRHS no son un fin en sí mismos, sino instrumentos para orientar la planificación y la toma de decisiones informadas. La contextualización de la situación sanitaria del país y de las metas establecidas en sus políticas de salud permite reconocer la necesidad y la oportunidad de desarrollar un SIRHS capaz de monitorear su activo más importante: la fuerza de trabajo en salud.

Incorporar una lectura política y epidemiológica del contexto ayuda a definir prioridades, identificar brechas territoriales y alinear los esfuerzos institucionales con los desafíos reales del sistema. Esta comprensión compartida es la que otorga sentido al mapeo de actores y provee el propósito convocante para sumar a los distintos niveles y sectores al proceso de diálogo y coordinación.

Reconocimiento de la estructura político-administrativa del país

Antes de iniciar el mapeo de actores clave es necesario identificar la estructura político-administrativa del país, es decir, caracterizar su sistema de gobierno o régimen político y el modo en que el Estado organiza formalmente su territorio. Esta información resulta imprescindible para definir posteriormente la estrategia de gobernanza para el proceso de constitución de un SIRHS.

En este punto, el foco estará centrado principalmente en determinar si el país asume una organización territorial de tipo **unitario** o **federal**.

En la primera, existe un único centro de poder político que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio nacional, cuenta con un único poder legislativo y un único poder judicial. No obstante, un Estado unitario puede asumir diversos tipos según cómo organice internamente la autonomía de sus territorios subnacionales.

En los Estados federales, la organización política y territorial resulta más compleja. Existe un ordenamiento jurídico nacional que cuenta con funciones de regulación, y cuya jurisdicción federal coexiste con las locales. En este esquema, las entidades federativas pueden adoptar su propia organización interna política y administrativa, es decir, son Estados conformados por entidades soberanas y autónomas.

Por otra parte, resulta necesario identificar el grado de autonomía que posee el nivel local/municipal para la gestión de los RHS —reflejado principalmente en su capacidad de contratar personal de salud—, así como su vinculación con el nivel nacional y subnacional. Esto resulta independiente de la organización unitaria o federal del país.

Asimismo, en cuanto a la función de regulación del ejercicio profesional, es importante reconocer los vínculos entre los consejos/colegios profesionales y los distintos niveles de gobierno.

Las características y los alcances de los convenios, acuerdos y regulaciones que deban generarse a futuro para consolidar el proceso de gobernanza sobre los SIRHS dependen en gran medida de estas definiciones sobre la estructura político-administrativa del país.

Reconocimiento del modelo de atención de la salud

Los sistemas de salud pueden ser clasificados de distintas maneras. La clasificación más difundida es según su tipo de financiamiento y organización. Esto se encuentra vinculado con la cobertura (es decir, quiénes tienen derecho a acceder a los servicios) y con el tipo de prestación (22).

En la Región, los tres modelos de financiamiento más frecuentes son: los esquemas gubernamentales, los esquemas obligatorios contributivos de la seguridad social y los esquemas voluntarios de pago de servicios de salud. Esta clasificación puede corresponderse con lo que comúnmente se denomina *sistema público, de la seguridad social y privado*.

Los esquemas gubernamentales son financiados y gestionados por el Estado a través de impuestos.

Los esquemas obligatorios contributivos de la seguridad social son modelos que buscan proporcionar cobertura médica a la población mediante un enfoque de financiación colectiva. Se financian principalmente a través de contribuciones obligatorias de empleadores y empleados, lo que permite proporcionar el acceso a servicios de salud a todos los trabajadores registrados y, en muchos casos, a sus familias. La atención suele ser gratuita o de bajo costo en el punto de atención, dependiendo de la estructura del sistema. Generalmente están administrados por entidades públicas o semipúblicas, que son responsables de la organización y supervisión de los servicios de salud.

Los esquemas voluntarios de pago de servicios de salud se basan en pagos directos de los usuarios o seguros de salud privados a los prestadores de salud, que son también gestionados desde el ámbito privado. En este sentido, el acceso depende de la capacidad de pago o de la cobertura del seguro.

Es frecuente encontrar la coexistencia de estos modelos de financiamiento en la Región.

Actores internos del Ministerio de Salud potencialmente involucrados en la conformación de un SIRHS

Se propone comenzar identificando los actores y fuentes de datos que se encuentran dentro del ámbito del Ministerio de Salud (MS).

Es probable que distintos departamentos dentro de los MS registren o recopilen datos similares. La consolidación de los registros de referencia es beneficiosa tanto desde una perspectiva estadística como desde una administrativa, ya que posibilitará estandarizar y mejorar la gestión y el aprovechamiento de los datos compartidos en todo el organismo, lo que se traduce en una mayor integración, coherencia y eficiencia en el manejo de la información y los recursos.

Exploración del organigrama y las funciones del Ministerio de Salud

Mediante el análisis del organigrama se pretende identificar las **áreas clave** dentro del MS que, entre sus objetivos y funciones, tengan a su cargo la **registración, regulación o gestión del personal de salud, así como el soporte técnico, jurídico** o de la **consolidación** y el **monitoreo de la información** dentro del MS (véase el recuadro 3).

Este mapeo interno permitirá a la Unidad Estratégica de RHS reconocer los posibles actores para la conformación de una mesa de trabajo sobre RHS y la capacidad existente dentro del MS.

En países federales o en aquellos donde se hayan delegado potestades de regulación del ejercicio en colegios o consejos profesionales, es probable que los responsables deban rastrearse fuera de los MS. Por ello se sugiere realizar un correcto reconocimiento de la estructura político-administrativa del país.

RECUADRO 3 ÁREAS INVOLUCRADAS SEGÚN MISIÓN Y FUNCIÓN

Se propone a continuación una serie de tareas clave dentro de las misiones y funciones del organigrama del MS que faciliten la identificación de las áreas pertinentes para la conformación de un SIRHS.

1. Registración, habilitación, regulación y fiscalización:

- Misión del área/de las áreas:
 - Gestionar los registros y habilitaciones de profesionales y establecimientos de salud, así como la regulación y fiscalización de sus actividades.
- Funciones clave:
 - Registro de profesionales de la salud (matrículas, idoneidades, licencias, acreditaciones, especialidades).
 - Registro y habilitación de establecimientos de salud.
 - Fiscalización y regulación de prácticas profesionales y establecimientos.

2. Gestión de RHS:

- Misión del área/de las áreas:
 - Administrar y gestionar el personal de salud en el subsector público (nacional, subnacional), asegurando la correcta contratación, liquidación y manejo de legajos.
- Funciones clave:
 - Reclutamiento, contrataciones, vínculos laborales, liquidaciones y legajos de personal (incluyendo residentes y becarios).

3. Soporte y gestión de TIC:

- Misión del área/de las áreas:
 - Brindar soporte técnico y gestionar los sistemas de información que facilitan el intercambio y la administración de datos (incluidos los relativos a RHS).
- Funciones clave:
 - Gestión de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la administración de RHS.
 - Infraestructura técnica para el intercambio de datos.
 - Soporte en la interoperabilidad entre sistemas de información.

4. Jurídicos y gestión de convenios:

- Misión del área/de las áreas:
 - Asegurar el cumplimiento normativo y gestionar los convenios relacionados con la administración general del MS (incluidos los relativos a RHS).
- Funciones clave:
 - Elaboración y revisión de normativas vinculadas a la habilitación de profesionales y establecimientos.
 - Gestión de convenios con otros organismos e instituciones del sector salud.

5. Estadística y planificación estratégica:

- Misión del área/de las áreas:
 - Consolidar y monitorear datos relevantes sobre servicios de salud, generando indicadores y estadísticas que apoyen la toma de decisiones dentro del MS.
- Funciones clave:
 - Generación de estadísticas e indicadores dentro del MS, basados en la información disponible de los servicios de salud.
 - Suministro de datos que permitan evaluar la situación sanitaria y apoyar la planificación estratégica.
 - Consolidación de datos provenientes de distintas fuentes para asegurar una visión integral y actualizada del sistema de salud.

6. Otras áreas relevantes:

- Misión del área/de las áreas:
 - Monitorear y gestionar información relacionada con redes, programas específicos y profesionales no habilitados que juegan un rol en el sistema de salud.
- Funciones clave:
 - Monitoreo de información sobre profesionales no habilitados (agentes comunitarios, medicina tradicional, etc.) y su rol en la prestación de servicios de salud.
 - Gestión de redes o programas asociados a los establecimientos de salud, como los programas de atención primaria o salud mental.
 - Fiscalización de establecimientos y personal del sector privado y la seguridad social.

MS: Ministerio de Salud; RHS: recursos humanos para la salud; SIRHS: sistema de información de recursos humanos para la salud; TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones.

Identificación de actores que gestionan registros de referencia (proveedores de información)

El eje vertebral de un SIRHS estará vinculado a la capacidad del MS de identificar y fortalecer los registros de referencia, lo que permitirá progresivamente estandarizar, vincular o validar los datos obtenidos de las diversas fuentes identificadas como pertinentes entre los distintos subsistemas (público, privado y de seguridad social) y sectores (educación, trabajo, migraciones, etc.).

Este es un proceso iterativo y retroalimentado, que puede iniciarse a partir de cualquiera de los dos registros de referencia —el de establecimientos o el de profesionales—, dependiendo de cuál se identifique como más robusto y con mayor capacidad de rectoría. En la matriz de relevamiento de actores, estos registros se incluirán dentro de la categoría “proveedores de información de registros de referencia”.

El proceso de mapeo se inicia con la identificación de las áreas encargadas de gestionar administrativamente estos registros, la normativa asociada a ellos, los procesos registrales, los datos colectados y las integraciones existentes. Para este fin, se adjunta una serie de guías (anexo 2) con preguntas ordenadoras, que pueden utilizarse a modo de *checklist* durante esta etapa.

Las guías mencionadas son aplicables para el reconocimiento de actores externos en el caso de funciones delegadas. En estas situaciones, la posibilidad de generar mecanismos de intercambio de información estará sujeta a la definición de consensos estratégicos y convenios.

Identificación de actores que gestionan registros auxiliares (proveedores de información y usuarios de datos)

Una segunda etapa del mapeo consistirá en identificar, dentro del MS, aquellas áreas que gestionan o requieren información relevante y oportuna sobre RHS.

Entre los **proveedores de información auxiliar** se sugiere inicialmente la identificación del área de gestión de personal del MS, ya que los registros de planteles del subsector público configuran una línea de base respecto de la disponibilidad de RHS.

Se pueden encontrar diversas áreas en los ministerios que, por sus objetivos, recolectan de forma parcial datos sobre RHS. Estas áreas pueden proporcionar información que enriquezca y clasifique dimensiones particulares sobre RHS. Un ejemplo son los **agentes o trabajadores comunitarios**, cuya identificación puede ser dificultosa a partir de los registros de personal del MS, pero que pueden estar más claramente identificados por las áreas de atención primaria de la salud, ya que son estas las encargadas de gestionarlos. Otro ejemplo son las áreas que se encargan de la gestión de profesionales en formación que prestan servicio (residentes).

Por otro lado, existen áreas que requieren información de RHS para el cumplimiento de misiones o programas específicos, como pueden ser los programas de salud bucodental, nutrición, salud escolar, maternidad e infancia o atención primaria. Estos **usuarios de datos** internos muchas veces consolidan en paralelo información de RHS, lo que lleva a una duplicación de esfuerzos. Al unificar estas iniciativas, se podrá solidificar la construcción y el desarrollo del SIRHS, contemplar necesidades específicas y mejorar la asignación de recursos.

Identificación de áreas de soporte legal y tecnológico

Debe convocarse al equipo coordinador a las áreas que proporcionan el **soporte legal y tecnológico** necesario para la integración administrativa y tecnológica de un SIRHS. Las áreas legales proveen apoyo para establecer convenios y los marcos normativos que permiten el intercambio seguro y confidencial de datos entre las diferentes entidades.

Por otro lado, el área de infraestructura tecnológica es la encargada de desarrollar soluciones interoperables y proporcionar el soporte técnico necesario. Una infraestructura sólida garantiza que el SIRHS pueda adaptarse a las necesidades cambiantes, integrar diferentes sistemas y mejorar la eficiencia en la gestión de datos.

Actores externos al Ministerio de Salud potencialmente involucrados en la conformación de un sistema de información de recursos humanos para la salud

Una vez establecida la mesa interna en el MS para la conformación de un SIRHS, se propone abordar un **mapeo ampliado** de actores con el fin de identificar e integrar la información del MS con fuentes externas relevantes (**proveedores de información**).

Este proceso generalmente requiere la participación de decisores de alto nivel que puedan habilitar canales de comunicación efectivos. El mapeo extendido debe dividirse entre actores pertenecientes a la administración pública nacional, la administración pública subnacional y aquellos de la seguridad social, del sector privado o de la sociedad civil. Es probable que, en muchos países, el MS mantenga una relación previa con ellos.

Resulta fundamental la alianza del MS con los ministerios de Educación o aquellos organismos que gestionen datos sobre formación para establecer una línea de base de RHS, según los módulos de las cuentas nacionales del personal de salud.

Relevamiento de datos de registros

Una vez finalizado el mapeo, el equipo coordinador debería contar con un primer diagrama de actores. Este insumo será clave para desarrollar una hoja de ruta hacia la conformación del SIRHS. No obstante, se trata de un proceso gradual que evolucionará con el tiempo, a medida que se profundice el conocimiento sobre las áreas e instituciones involucradas y se identifiquen nuevas interacciones y necesidades.

Para esta etapa, se propone utilizar una metodología de entrevistas semiestructuradas, comenzando por las áreas responsables de los registros de referencia y de los planteles de RHS, señaladas como la base para la construcción del SIRHS (véase el recuadro 4).

Se ha elaborado una serie de guías para el relevamiento **de instrumentos normativos, procesos de registro, variables relevantes e integraciones de datos vinculados con profesionales habilitados, establecimientos de salud y nóminas de personal de salud**. Estas guías abarcan tanto el ámbito nacional y subnacional como el de las entidades responsables de la regulación y fiscalización del ejercicio profesional (consejos, colegios profesionales, entre otros).

Luego de la instancia de entrevistas, se propone que el área de RHS realice un *checklist* de las respuestas utilizando como insumo la información obtenida durante dicha instancia. Para esto, se puede utilizar también la *Matriz comparativa para la integración de registros* (planilla en Excel: <https://www.paho.org/es/documentos/matriz-comparativa-para-integracion-registros>).

En una segunda instancia, se debería realizar una indagación específica de la infraestructura tecnológica, sistemas existentes y particularidades técnicas que pueden requerir la presencia del área de sistemas o TIC. Es conveniente dejar dichos contenidos para segundos encuentros, una vez que se haya podido definir la pertinencia, exhaustividad, actualización y calidad de los datos relevados previamente.

RECUADRO 4 RECOMENDACIONES PARA ENTREVISTAS

Se propone realizar las entrevistas con una dinámica abierta, con base en una serie de preguntas de carácter cualitativo, flexibles, y que operen como orientadoras de la conversación. Asimismo, se sugiere que las entrevistas sean grabadas o documentadas mediante minutas.

Se recomienda llevar a cabo una segunda reunión para evaluar las preguntas que no hayan sido respondidas o para incorporar nuevas preguntas que puedan surgir a partir de los datos recopilados.

Concertación y formalización de acuerdos estratégicos

En la etapa final, el equipo coordinador habrá generado un conjunto de insumos interconectados que servirán para reorganizar la hoja de ruta y guiar las siguientes etapas del proyecto.

Estos insumos incluyen: *i)* una matriz y un diagrama de actores, *ii)* una caracterización preliminar de los RRAA base, y *iii)* la identificación de posibles modelos de convenios entre las áreas.

Matriz y diagrama de actores

La matriz clasifica a los actores según el nivel de rectoría del MS y su relevancia, mientras que el diagrama representa visualmente las relaciones entre estos y los flujos de información (véase el anexo 3). Ambos productos permitirán identificar prioridades, planificar intervenciones y estructurar etapas de trabajo.

Acciones sugeridas

- Priorizar áreas bajo rectoría directa del MS para organizar grupos de trabajo específicos.
- Utilizar el diagrama para proponer optimizaciones de los flujos de información, detectando cuellos de botella o redundancias y definiendo relaciones más eficientes.
- Expandir progresivamente la búsqueda hacia actores periféricos fuera del MS, poniendo el foco en registros educativos y subnacionales.

Caracterización de registros y análisis de calidad de datos

Durante la caracterización de los RRAA se habrán identificado las variables clave, la normativa asociada y los soportes tecnológicos vinculados. Esto permite delinear una primera evaluación sobre la compatibilidad, la calidad y el potencial de integración de los datos.

Para avanzar en esta línea, será necesario gestionar el acceso formal a los datos reales de los registros identificados, con el objetivo de analizar su calidad y proponer opciones para estructurar la integración.

Este proceso requerirá contar con entornos tecnológicos que permitan el acceso seguro a los datos, preservando la confidencialidad, la integridad y la trazabilidad de la información. Por lo tanto, entre las acciones por priorizar debe incluirse el diseño e implementación de dichas soluciones tecnológicas.

Acciones sugeridas

- Formalizar acuerdos para el acceso a los registros identificados durante el relevamiento, que permitan la disponibilidad de los datos para su análisis y validación.
- A partir de este análisis, seleccionar los registros más sólidos para iniciar la integración.
- Diseñar claves de vinculación, como identificadores personales o tributarios, para conectar al personal de salud en las bases de datos y estructurar información de manera confiable.
- Proponer estándares comunes (clasificadores y codificaciones, preferentemente internacionales) para garantizar la interoperabilidad entre registros.
- Desarrollar y poner a disposición entornos tecnológicos que permitan el acceso seguro a los registros, asegurando la confidencialidad, la integridad y la trazabilidad de los datos para todos los actores involucrados.

Construcción de consensos e instrumentación mediante convenios o acuerdos de gestión

En el marco de un SIRHS basado en la integración de registros, los convenios son las herramientas que permiten garantizar el acceso a los datos, la periodicidad de la actualización y la sostenibilidad del sistema. Es fundamental poder rastrear en el proceso de entrevistas su existencia o la potencialidad de su suscripción. Su diseño debe reflejar las prioridades definidas en la matriz y en el diagrama de actores, y estar alineado con los resultados del análisis de registros.

Acciones sugeridas

- Realizar un encuentro de consenso y sensibilización con los actores identificados como clave para alinear objetivos, fortalecer compromisos y promover una colaboración efectiva en la gestión de datos.
- Redactar convenios con áreas clave (o acuerdos de gestión con áreas bajo rectoría directa del MS), que permitan el acceso a los datos, su actualización y protección.
- Incorporar en los convenios mecanismos específicos para implementar flujos de información, tal como lo define el diagrama de actores.
- Establecer un sistema de monitoreo que permita ajustar estrategias según necesidades emergentes.

Revisión de la hoja de ruta

En esta etapa, es oportuna la reorganización de la hoja de ruta mediante la integración de los insumos generados. Se priorizarán acciones que aseguren y formalicen el acceso a los datos, así como su intercambio, y la vinculación de registros con mayor calidad y compatibilidad.

Acciones clave

- Establecer una nueva secuencia y plan de acciones priorizando la interacción entre los actores y registros más relevantes, así como aquellos con mayor potencial de implementación inmediata.
- Establecer metas concretas y escalables para el análisis y la integración de registros, consensuadas con los actores.
- Incorporar indicadores para monitorear la calidad de los datos, la efectividad de los convenios y el fortalecimiento de la gobernanza del sistema.

La identificación de los actores no es un ejercicio puntual, sino la base de una hoja de ruta viva (véase el anexo 4).

Esta hoja de ruta evoluciona a medida que las instituciones perfeccionan sus funciones, armonizan las normas y crean confianza mutua. Así, se convierte en un producto compartido, sostenido conjuntamente por todos los actores que contribuyen al ecosistema de información sobre el personal de salud.

Orientaciones para el desarrollo del mapeo de actores

Como material anexo al presente documento, se incluye una serie de orientaciones para el desarrollo del mapeo de actores de RRAA de RHS. Tal como se mencionó, estas directrices son de carácter orientativo y flexible, por lo que deberán ajustarse a la realidad de los distintos países de la Región. Los materiales incluidos en los anexos son:

1. Guía de autoevaluación de la Unidad Estratégica de RHS (anexo 1).
2. Guías para el relevamiento de registros oportunos para la consolidación de un SIRHS, que incluyen el relevamiento de: *i)* registros de profesionales de la salud habilitados; *ii)* registros de establecimientos de salud, y *iii)* registros de nóminas/contratos de personal (anexo 2).
3. Matriz para el relevamiento de actores de RHS (anexo 3).
4. Secuencia sugerida para la implementación y seguimiento de la hoja de ruta del mapeo de actores (anexo 4).
5. *Matriz comparativa para la integración de registros* (planilla en Excel: <https://www.paho.org/es/documentos/matriz-comparativa-para-integracion-registros>).

Conclusiones

La conformación de un sistema de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) es esencial para abordar las desigualdades en la distribución del personal de salud y optimizar la gestión de los recursos humanos para la salud (RHS). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha destacado la necesidad de disponer de información para la planificación, formulación de políticas y toma de decisiones estratégicas en el sector de la salud. No obstante, uno de los principales desafíos identificados es la fragmentación de los sistemas de información existentes, que suelen operar de manera aislada y sin una estrategia de gobernanza unificada. Esta fragmentación limita la capacidad de integrar datos provenientes de diversas fuentes administrativas, lo que tiene como consecuencia la duplicación de esfuerzos y la dificultad para contar con información precisa, oportuna y actualizada sobre las dimensiones relevantes de los RHS.

En el presente documento, se ha desarrollado una **propuesta de gobernanza** para la implementación del SIRHS centrada en el diálogo político y en la utilización de datos provenientes de registros administrativos (RRAA) tanto pertenecientes al Ministerio de Salud (MS) como externos a este. A diferencia de otros métodos de recolección de datos primarios tradicionales, como los censos y las encuestas, los RRAA son aún un activo poco explotado por los Estados, que permiten la captación de datos de manera continua, con mayor cobertura y a un costo reducido.

No obstante, como se ha señalado, la utilización de RRAA con fines estadísticos enfrenta desafíos significativos, como la variabilidad en la calidad y completitud de los datos, el bajo grado de madurez de la infraestructura tecnológica, y la limitada disponibilidad de recursos financieros y humanos. Superar estos desafíos requerirá un trabajo de conceptualización, modelización y definición de estándares y, sobre todo, de liderazgo, consenso y articulación entre actores.

La **metodología de mapeo y diálogo estratégico de actores** para la gobernanza de SIRHS desarrollada en este documento se presenta como la principal herramienta para abordar estos retos y fortalecer la gobernanza de cara a la conformación de un SIRHS. Se concibe desde una perspectiva continua e integradora: comienza en las áreas donde el MS tiene mayor capacidad de rectoría, consolidando así el núcleo de gobernanza, y se expande progresivamente hacia otras áreas estratégicas tanto dentro como fuera del sector público. El mapeo servirá para las siguientes acciones:

- **Explorar y comprender las relaciones** entre los diversos actores involucrados en la gestión de RHS.
- **Identificar necesidades específicas de información** sobre RHS para determinar oportunidades de intercambio.
- **Facilitar la coordinación multisectorial** y la construcción y sustentabilidad de alianzas efectivas que optimicen el flujo de información.
- **Optimizar los flujos de información** mediante la formalización de convenios y la adopción de estándares comunes.

Por otro lado, la adopción de estándares comunes nacionales e internacionales (como la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones) será fundamental para garantizar la comparabilidad de los datos en el camino hacia la interoperabilidad de los sistemas. Asimismo, la utilización del marco propuesto por las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) (23) es clave para definir objetivos claros sobre qué medir (formación, ocupación y sector de actividad).

La implementación de un SIRHS basado en RRAA debe entenderse como un proceso dinámico que requiere de un **ciclo de retroalimentación continua, participativo y dialógico**. Este ciclo abarca los siguientes elementos:

1. **Conceptualización:** definir lo que se va a medir, mapear actores clave, identificar registros y diseñar estándares consensuados.
2. **Implementación:** poner en marcha los procesos de integración, formalizar convenios y construir las infraestructuras tecnológicas necesarias.
3. **Revisión continua:** evaluar regularmente el funcionamiento del sistema, identificar brechas, medir avances y ajustar estrategias conforme a las necesidades emergentes y al diálogo entre los actores.

La metodología propuesta es flexible; incluso una implementación parcial puede ayudar a los países a comenzar a crear gobernanza y, con el tiempo, a transformar la coordinación en un sistema sostenible de datos sobre RHS.

Cada nación posee contextos administrativos, sanitarios y culturales específicos, así como una trayectoria en el desarrollo de SIRHS, que determinarán distintos puntos de partida para la integración de las fuentes de datos. Por lo tanto, es imprescindible adaptar y validar la metodología de acuerdo con los objetivos de las políticas públicas, y las necesidades y capacidades locales.

Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud 2019-2023: Informe final [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2024. Disponible en: <https://www.paho.org/sites/default/files/2024-12/cd61-inf-7-s-sistemas-informacion-2019-2023-rep1.pdf>.
2. Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: Personal sanitario 2030 [Internet]. 69.ª Asamblea Mundial de la Salud; del 23 al 28 de mayo del 2016. Ginebra: OMS; 2016. Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R19-sp.pdf.
3. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 29.ª Conferencia Sanitaria Panamericana; del 25 al 29 de septiembre del 2017. Washington, D.C.: OPS; 2017.
4. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023. 162.ª sesión del Comité Ejecutivo; del 18 al 22 de junio del 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018.
5. Organización Panamericana de la Salud. Política sobre el personal de salud 2030: Fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/politica-sobre-personal-salud-2030-fortalecimiento-recursos-humanos-para-salud-fin>.
6. Tapella E. El mapeo de actores claves: documento de trabajo del proyecto "Efectos de la biodiversidad funcional sobre procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y sustentabilidad en las Américas: Un abordaje interdisciplinario" [Internet]. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, IAI; 2007. Disponible en: <https://planificacionsocialunsj.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf>.
7. Gopal S, Clarke T. Guide to Actor Mapping [Internet]. Reimaging Soc. Chang. 2017;1–14. Disponible en: <https://www.fsg.org/tools-and-resources/guide-actor-mapping>.
8. Wallgren A, Wallgren B. Estadísticas basadas en registros. México: INEGI; 2016.
9. Wallgren A, Wallgren B. Hacia un sistema estadístico integrado y basado en registros [Internet]. Washington, D.C.: BID; 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.18235/0003204>.
10. Dal Poz MRD, Gupta N, Quain E, Soucat AL (eds.). Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud, con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos [Internet]. Ginebra: OMS; 2009. Disponible en: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/d29c0539-f495-4200-8a01-570df61a12e4/content>.
11. Sistema de Información Estadística Local. Tratamiento de los registros administrativos: primera parte. Cuadernos del SIEL Serie 1: Materiales institucionales, conceptuales y metodológicos, Cuaderno n.º 6. Buenos Aires: INDEC; 2008. Disponible en: https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/2mi548_5.pdf.
12. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Documento metodológico para el aprovechamiento estadístico de registros administrativos económicos [Internet]. Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Reunión virtual del 23 al 25 de noviembre del 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11362/47461>.
13. Martineau T, Ozano K, Raven J, Mansour W, Bay F, Nkhoma D, et al. Improving Health Workforce Governance: The Role of Multi-Stakeholder Coordination Mechanisms and Human Resources for Health Units in Ministries of Health. Hum Resour Health [Internet]. 2022;20(1). Disponible en: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85130759950&doi=10.1186%2Fs12960-022-00742-z&partnerID=40&md5=d3f4f5aab8fe4644dc88323cb80661ef>.
14. Indarte S, Pazos Gutiérrez P. Estándares e interoperabilidad en salud electrónica [Internet]. Santiago de Chile: CEPAL; 2011. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/53545c4a-b5e7-40fa-b338-50bfc29d1268/content>.

15. Organización Panamericana de la Salud. Introducción a la interoperabilidad semántica [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54797>.
16. Organización Panamericana de la Salud. Gobernanza de datos en salud pública [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2019. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57023/OPSEIHISdttkt23220027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
17. Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, et al. A Universal Truth: No Health Without a Workforce [Internet]. Forum Report, Third Glob. Forum Hum. Resour. Heal. 2013. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/hrh_universal_truth.
18. Tavares RA de A, Ortega Nieto D, Woodhouse EF. Government Analytics Using Human Resources and Payroll Data [Internet]. En: Rogger D, Schuster C. The Government Analytics Handbook: Leveraging Data to Strengthen Public Administration. Washington, D.C.: Banco Mundial; 2023. Disponible en: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/dbb70655-a709-4bdd-b250-b3097f04a1de/download>.
19. Figlio D, Karbownik K, Salvanes KG. Chapter 2: Education Research and Administrative Data [Internet]. En: Hanushek EA, Machin S, Woessmann L (eds.), Handbook of the Economics of Education. Ámsterdam: Elsevier; 2016: 75–138. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444634597000026>.
20. Brockemeyer A. Working with Administrative Tax Data: A How-to-Get-Started Guide [Internet]. World Bank Blogs; 2019. Disponible en: <https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/working-administrative-tax-data-how-get-started-guide>.
21. Organización Internacional para las Migraciones. Characteristics of the Process for Gathering and Using Administrative Records on Migration in Central America, Mexico and the Caribbean [Internet]. Ginebra: OIM; 2019. Disponible en: https://kmhub.iom.int/sites/default/files/2022-02/rpcc-final_eng-dig_0.pdf.
22. Organización Mundial de la Salud. Un sistema de cuentas de salud 2011 - edición revisada. Ginebra: OMS; 2022.
23. Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: un manual [Internet]. Segunda edición. Ginebra: OMS; 2023. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/376012>.

Anexo 1.

Guía de autoevaluación de la Unidad Estratégica de Recursos Humanos para la Salud

Autoevaluación de la Unidad Estratégica de Recursos Humanos para la Salud

1. Información general

Nombre del área:

Repartición:

2. Recolección y manejo de datos

¿Qué tipo de datos de recursos humanos para la salud (RHS) se relevan/compilan rutinariamente? (Seleccione todas las que apliquen)

- Nóminas de empleados del subsector público (contratados, becarios, etc.)
- Nóminas de empleados del subsector privado
- Registros de titulaciones de pregrado, grado o posgrado (formaciones)
- Licencias/habilitaciones/certificaciones profesionales
- Otro (especificar): _____

Frecuencia de recolección de datos:

- Semanal
- Mensual
- Semestral
- Anual
- A demanda
- Otro (especificar): _____

Los datos del subsector público contemplan información del nivel:

- Nacional
- Subnacional del primer orden (regiones, provincias, estados)
- Subnacional del segundo orden (municipal, departamental)
- Otro (especificar): _____

3. Uso de datos y reportes

¿Se emiten informes estandarizados de forma regular?

- Sí
- No

Regularidad en la producción de informes:

- Mensual
- Semestral
- Anual
- A demanda
- Otro (especificar): _____

¿Se publican conjuntos de datos abiertos?

- Sí
- No

Principales usuarios de los datos e informes de RHS:

- Ministerio de Salud
- Áreas/departamentos de salud pública a nivel subnacional
- Otros ministerios
- Investigadores/docentes
- Entidades del sector privado
- ONG, asociaciones civiles, entidades religiosas, etc.
- Reguladores de profesionales de la salud
- Público general
- Otro (especificar): _____

4. Sistemas implicados y administradores de los sistemas

¿Qué sistemas están implicados en la gestión de datos de RHS? (Seleccione todas las que apliquen)

- Sistema/registro de profesionales habilitados a nivel nacional
- Sistema/registro de establecimientos habilitados a nivel nacional
- Sistema de gestión de nóminas de recursos humanos
- Sistema de seguimiento de capacitación
- Sistema de evaluación de desempeño
- Otro (especificar): _____

¿Quiénes administran o brindan soporte de estos sistemas? (Seleccione todas las que apliquen)

- Departamento de Tecnología de la Información
- Proveedores externos
- Otro (especificar): _____

5. Identificación de datos necesarios

¿Qué datos considera críticos para la gestión y planificación eficiente de RHS? (Seleccione todas las que apliquen)

- Información de empleados
- Datos de desempeño laboral
- Información sobre beneficios y compensaciones
- Profesionales registrados o habilitados
- Egresados universitarios
- Especialistas formados
- Especialistas en formación
- Historial de capacitación y desarrollo
- Datos de retención y rotación de personal
- Salud del trabajador
- Otro (especificar): _____

¿Cómo se garantiza la calidad y precisión de los datos recolectados? (Seleccione todas las que apliquen)

- Validaciones automáticas en el sistema
- Revisiones manuales periódicas
- Capacitación continua del personal encargado
- Uso de estándares de datos
- Otro (especificar): _____

6. Desafíos

¿Cuáles son las principales dificultades enfrentadas en la gestión de datos de RHS? (Seleccione todas las que apliquen)

- Falta de integración entre sistemas
- Calidad inconsistente de los datos
- Problemas para relevar información a nivel subnacional
- Dificultades para captar datos a nivel del establecimiento
- Limitaciones de recursos tecnológicos
- Falta de capacitación del personal
- Otro (especificar): _____

¿Qué acciones le parece que pueden llevarse a cabo para superar estas dificultades? (Seleccione todas las que apliquen)

- Implementación de nuevas herramientas tecnológicas
- Capacitación y desarrollo del personal
- Mejoras en los procesos de recolección de datos
- Contratación de personal adicional
- Otro (especificar): _____

Anexo 2.

Guías para el relevamiento de registros oportunos para la consolidación de un sistema de información de recursos humanos para la salud

A continuación, se presenta una serie de guías para el relevamiento de instrumentos **normativos, procesos de registro, variables relevantes e integraciones de datos vinculados con profesionales habilitados, establecimientos de salud y nóminas del personal de salud**. Estas guías abarcan el ámbito nacional y el subnacional, así como entidades responsables de la regulación y fiscalización del ejercicio profesional (consejos y colegios profesionales, entre otras).

Se propone realizar las entrevistas con una dinámica abierta, con base en una serie de preguntas de carácter cualitativo, flexibles, y que operen como orientadoras de la conversación. Se sugiere que las entrevistas sean grabadas o documentadas mediante minutas.

Luego de la entrevista se recomienda al área de recursos humanos para la salud (RHS) hacer un *checklist* de las respuestas utilizando como insumo la información obtenida durante las entrevistas. Para esto, se puede utilizar también la *Matriz comparativa para la integración de registros*.

Asimismo, se recomienda llevar a cabo una segunda reunión para evaluar las preguntas que no hayan sido respondidas o para incorporar nuevas preguntas que puedan surgir a partir de los datos recopilados (este proceso se detalla en el apartado **Concertación y formalización de acuerdos estratégicos**).

Junto a las presentes guías, se propone un relevamiento específico de los sistemas de registros de infraestructura tecnológica, sistemas existentes y particularidades técnicas que pueden requerir la presencia del área de sistemas o tecnologías de la información y las comunicaciones. No obstante, se propone dejar dicho contenido para segundos encuentros, una vez que se han podido definir la pertinencia, la exhaustividad, la actualización y la calidad de los datos relevados previamente.

Guía para el relevamiento de registros de profesionales de la salud habilitados

1. Información general

Nombre oficial del registro

¿Cuál es la denominación oficial del registro de profesionales de la salud habilitados?

Fecha de inicio

¿Desde cuándo está en funcionamiento el registro?

Entidad responsable

¿Qué área o entidad es responsable de la gestión y administración del registro?

Marco normativo

¿Qué normativas, leyes o regulaciones sustentan la existencia y el funcionamiento del registro? (por ejemplo, resoluciones, convenios, decretos).

Objetivo principal

¿Cuál es el propósito principal del registro?

2. Características de los datos registrados

Profesiones incluidas

¿Qué profesiones del ámbito de la salud están incluidas en el registro? (Seleccione todas las que apliquen)

- Médicos (grado universitario)
- Enfermeros (grado universitario)
- Farmacéuticos (grado universitario)
- Fisioterapeutas (grado universitario)
- Matronas/parteras/obstetras (grado universitario)
- Dentistas (grado universitario)
- Psicólogos (grado universitario)
- Nutricionistas (grado universitario)
- Terapeutas ocupacionales (grado universitario)
- Técnicos/tecnólogos (enfermería, laboratorio, radiología, imágenes, emergencias, etc.)
- Auxiliares o asistentes de enfermería
- Otros (especificar) _____

Datos filiatorios

¿Cuáles son los datos filiatorios que se capturan para cada profesional? (Seleccione todas las que apliquen)

- Nombre completo
- Sexo/género
- DU/RUT/DNI/CI
- País de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Domicilio
- Teléfono
- Correo electrónico
- Otro (especificar) _____

Formación profesional

¿Qué información relativa a la formación académica se registra para cada profesional? (Seleccione todas las que apliquen)

- Titulación obtenida
- Fecha de titulación
- Institución formadora
- Procesos de revalidación o convalidación de títulos
- Otro (especificar) _____

Habilitación profesional

¿Qué datos de habilitación profesional se capturan? (Seleccione todas las que apliquen)

- Número de licencia
- Fecha de alta
- Fecha de vencimiento de la licencia
- Renovaciones
- Sanciones/inhabilitaciones
- Otro (especificar) _____

Especialidades

¿Qué información sobre especialidades profesionales se registra? (Seleccione todas las que apliquen)

- Fecha de certificación
- Entidad certificadora
- Área de especialización
- Otro (especificar) _____

¿Cuál es la cobertura geográfica del registro?

- Nacional
- Subnacional
- Otro (especificar) _____

Estado de actividad de los profesionales

¿Es necesario una erogación para sostener la habilitación profesional?

- Sí
- No

En caso de que sea afirmativo, ¿cada cuánto?

- Mensual
- Semestral
- Anual
- Mayor al año

¿Existen procesos administrativos periódicos o puntuales para sostener la habilitación profesional (rehabilitación/recertificación)?

- Sí
- No

En caso de que sean periódicos, ¿cada cuánto?

- Mensual
- Semestral
- Anual
- Mayor al año

¿Existen procesos de limpieza rutinaria de profesionales fallecidos?

- Sí
- No

En caso de que sea afirmativo, ¿cada cuánto?

- Mensual
- Semestral
- Anual
- Mayor al año

3. Procedimiento de carga de datos

Frecuencia de actualización

¿Con qué frecuencia se actualiza la información (altas, bajas o modificaciones)?

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Trimestralmente
- Anualmente
- Otro (especificar) _____

Nivel de centralización del proceso registral

¿La entrada de datos se realiza de manera centralizada o descentralizada (a nivel subnacional)?

- Centralizada
- Descentralizada
- Mixta
- Otro (especificar) _____

Responsables de datos

¿Quiénes son los encargados de proveer los datos al registro?

- Autoridades de salud a nivel nacional
- Autoridades de salud a nivel subnacional
- Colegios/consejos profesionales a nivel nacional o subnacional
- Autoridades/instituciones educativas que expiden titulaciones
- Otro (especificar) _____

Métodos de recolección y almacenamiento de datos

¿Cómo se recogen, registran y almacenan los datos?

- En papel
- Electrónicamente (plataforma web, sistema interno)
- Otro (especificar) _____

Revisiones periódicas

¿Existen eventos puntuales o períodos específicos del año en los que se realice una revisión o actualización masiva de los datos?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuáles son estos eventos o períodos? _____

4. Acceso a la información

Consulta de registro

¿El registro es de consulta pública?

- Sí
- No

En caso de que no sea de consulta pública o existan datos reservados, ¿es necesaria la firma de un convenio?

- Sí
- No

Exportación de datos (para registros relevados de manera electrónica)

¿El registro permite la exportación de datos para análisis externos por parte del usuario?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿en qué formatos se pueden exportar los datos?

- CSV
- Excel
- JSON
- XML
- Otro (especificar) _____

5. Integración con registros auxiliares

¿Este registro se integra con otros registros administrativos, sistemas de información o bases de datos?
(por ejemplo, registros de validación de personas, titulaciones, etc.)

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿con cuáles? _____

Guía para el relevamiento de registros de establecimientos de salud

1. Información general

Nombre oficial del registro

¿Cuál es la denominación oficial del registro de establecimientos?

Fecha de inicio de operaciones

¿Desde cuándo está en funcionamiento el registro?

Entidad responsable de la gestión

¿Qué área o entidad es responsable de la gestión y administración del registro?

Marco normativo

¿Qué normativas, leyes o regulaciones sustentan la existencia y el funcionamiento del registro? (por ejemplo, resoluciones, convenios, decretos)

Objetivo principal

¿Cuál es el propósito principal del registro?

2. Características de los datos registrados

Alcance y cobertura del registro

¿Qué tipo de establecimientos de salud están incluidos en el registro? (Seleccione todas las que apliquen)

- Hospitales generales y especializados (clínicas, sanatorios, etc.)
- Centros de atención ambulatoria general o especializada (atención primaria, postas, centros de salud, salud mental ambulatoria, etc.)
- Residencias de larga estadía (personas mayores, psiquiátricos, adicciones, etc.)
- Centros de rehabilitación física
- Unidades móviles
- Atención domiciliaria
- Laboratorios
- Farmacias
- Consultorios profesionales
- Otro (especificar) _____

¿Cuál es la cobertura geográfica del registro?

- Nacional
- Subnacional
- Otro (especificar) _____

¿El registro abarca tanto establecimientos públicos como privados?

- Sí
- No
- Parcialmente (especificar) _____

Tipologías de establecimientos

¿Existen tipologías estandarizadas para la clasificación de los establecimientos?

- Sí
- No
- Parcialmente (especificar) _____

¿Estas tipologías se derivan de procedimientos de acreditación, certificación o habilitación de establecimientos de la salud?

- Sí
- No
- Parcialmente (especificar) _____

En caso afirmativo, ¿cuáles son las tipologías utilizadas? (Seleccione todas las que apliquen)

- Basadas en el nivel de atención (primaria, secundaria, terciaria)
- Basadas en la especialidad (cardiología, pediatría, etc.)
- Basadas en la capacidad (número de camas, volumen de pacientes)
- Otro (especificar) _____

Datos generales del establecimiento

¿Cuáles son los campos de datos generales que se capturan en el registro? (Seleccione todas las que apliquen)

- Nombre oficial del establecimiento
- Código único de identificación
- Dirección completa (calle, número, ciudad, provincia)
- Coordenadas geográficas (latitud y longitud)
- Origen del financiamiento (público, privado, mixto)
- Dependencia administrativa (Ministerio de Salud, gobierno regional, privado, ONG, etc.)
- Horario/días de atención
- Fecha de creación/inauguración
- Estado operativo (activo, inactivo)
- Otro (especificar) _____

Dotaciones

¿Se registran datos sobre dotaciones de personal asociadas al establecimiento?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿la misma se encuentra nominalizada o agrupada (total de personal)?

- Nominalizada
- Agrupada

Si existe información nominalizada, indique qué datos se relevan de cada persona.

- Nombre y apellido

- Sexo/género
- DU/RUT/DNI/CI
- País de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Domicilio
- Formación/profesión
- Habilitación profesional
- Movimientos dentro del plantel (fecha de ingreso/fecha de egreso)
- Horas trabajadas
- Funciones
- Tipo de contrato de trabajo (agrupamiento/ley/escalafón)

Infraestructura y equipamiento

¿Se registran datos sobre la infraestructura del establecimiento? (equipamiento médico, camas, etc.)

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿qué aspectos de la infraestructura se capturan? (Seleccione todas las que apliquen)

- Número de camas
- Equipamiento médico
- Servicios/unidades funcionales (terapia intensiva, emergencias, etc.)
- Otro (especificar) _____

Estado de actividad de los establecimientos

¿Existen procesos administrativos periódicos o puntuales para sostener la habilitación del establecimiento (rehabilitación/reactuación)?

- Sí
- No
- Parcialmente (especificar) _____

En caso de que sean periódicos, ¿cada cuánto?

- Mensual
- Semestral
- Anual
- Mayor al año

3. Procedimiento de carga de datos

Frecuencia de actualización

¿Con qué frecuencia se actualiza la información en el registro (altas/bajas/modificaciones)?

- Diariamente
- Semanalmente
- Mensualmente
- Trimestralmente
- Anualmente
- Otro (especificar) _____

Nivel de centralización del proceso registral

¿La entrada de datos se realiza de manera centralizada o descentralizada (a nivel subnacional)?

- Centralizada
- Descentralizada
- Mixta
- Otro (especificar) _____

Responsables de datos

¿Quiénes son los encargados de proveer los datos al registro?

- Operadores a nivel nacional
- Operadores a nivel subnacional
- Operadores a nivel de establecimiento
- Otro (especificar) _____

Métodos de recolección y almacenamiento de datos

¿Cómo se recogen, registran y almacenan los datos?

- En papel
- Electrónicamente (plataforma web, sistema interno)
- Otro (especificar) _____

Revisiones periódicas

¿Existen eventos puntuales o períodos específicos del año en los que se realice una revisión o actualización masiva de los datos?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuáles son estos eventos o períodos? _____

4. Acceso a la información

Consulta de registro

¿El registro es de consulta pública?

- Sí
- No

En caso de que no sea de consulta pública o existan datos reservados, ¿es necesaria la firma de un convenio?

- Sí
- No

Exportación de datos (en caso de existir sistemas electrónicos)

¿El registro permite la exportación de datos para análisis externos por parte del usuario?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿en qué formatos se pueden exportar los datos?

- CSV
- Excel
- JSON
- XML
- Otro (especificar) _____

5. Integración con registros auxiliares

¿Este registro se integra con otros registros administrativos, sistemas de información o bases de datos?
(por ejemplo, registros de validación de personas, titulaciones, etc.)

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿con cuáles? _____

Guía para el relevamiento de registros de nóminas/contratos de personal

1. Información general

Marco normativo

¿Cuáles son las normativas, leyes y regulaciones que sustentan las distintas modalidades de contratación?

- Leyes principales _____
- Decretos y resoluciones _____
- Otras reglamentaciones _____

2. Datos relevados

Datos filiatorios

¿Cuáles son los datos filiatorios que se capturan para cada persona? (Seleccione todas las que apliquen)

- Nombre y apellido
- Sexo/género
- DU/RUT/DNI/CI
- País de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Domicilio

- Teléfono
- Correo electrónico
- Otro (especificar) _____

Formación académica

¿Se registra información académica de la persona?

- Sí
- No

¿Qué información relativa a la formación académica se registra para cada persona? (Seleccione todas las que apliquen)

- Formación/profesión
- Fecha de titulación
- Institución formadora
- Otro (especificar) _____

Habilitación profesional y especialidades

¿Se registra información asociada a habilitaciones profesionales?

- Sí
- No

Habilitación profesional

¿Qué datos de habilitación profesional se capturan? (Seleccione todas las que apliquen)

- Número de licencia
- Fecha de alta
- Fecha de vencimiento de la licencia
- Renovaciones
- Sanciones/inhabilitaciones
- Otro (especificar) _____

¿Se registra información de especialidades profesionales?

- Sí
- No

Especialidades

¿Qué información sobre especialidades profesionales se registra? (Seleccione todas las que apliquen)

- Fecha de certificación
- Entidad certificadora
- Área de especialización
- Otro (especificar) _____

Laborales y contractuales

¿Qué información relativa a contrataciones y puesto de trabajo se registra para cada persona? (Seleccione todas las que apliquen)

- Movimientos dentro del plantel (fecha de ingreso/fechas de egreso)
- Fecha de modificación de situación contractual
- Horas trabajadas
- Funciones
- Agrupamiento/ley/escalafón
- Establecimiento/repartición de trabajo
- Cargos jerárquicos

¿Qué modalidades de contratación se registran? (Seleccione todas las que apliquen)

- Contrato por obra o labor
- Contrato de trabajo a término fijo
- Contrato de trabajo a término indefinido
- Contrato de aprendizaje
- Contrato temporal, ocasional o accidental
- Otro (especificar) _____

3. Procedimiento de carga de datos

Nivel de centralización del proceso registral

¿La gestión de los movimientos de personal en el sistema (altas, bajas, modificaciones) se realiza de manera centralizada o descentralizada?

- Centralizada
- Descentralizada
- Mixta

Sistemas utilizados para el registro de nómina

¿Se utiliza un único sistema para gestionar la nómina de todos los empleados o se emplean múltiples sistemas?

- Único sistema (todos los empleados están gestionados a través de un solo sistema de nómina centralizado)
- Múltiples sistemas (se utilizan diferentes sistemas de nómina para distintos grupos de empleados o áreas)

Sistema de registro de RHS

- Nombre del sistema _____
- Fecha de implementación del sistema de registro de nómina _____
- Área responsable de la gestión y administración del sistema _____
- Objetivo principal del sistema de registro de nómina _____

En caso de múltiples sistemas, especificar cuáles, para qué tipo de personal o áreas involucradas _____

4. Acceso a la información

Exportación de datos

¿El registro permite la exportación de datos para análisis externos por parte del usuario?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿en qué formatos se pueden exportar los datos?

- CSV
- Excel
- JSON
- XML
- Otro (especificar) _____

5. Integración con registros auxiliares

¿Este registro se integra con otros registros administrativos, sistemas de información o bases de datos?
(por ejemplo, registros de validación de personas, titulaciones, etc.)

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿con cuáles? _____

Anexo 3.

Propuesta de matriz de relevamiento de actores de recursos humanos para la salud

CUADRO A3.1. Matriz de relevamiento

Categoría	+ Rectoría			- Rectoría	
	Estado			Sector privado/ seguridad social	Sociedad civil
	MS	Fuera del MS	Niveles subnacionales		
Decisores	Mesa de trabajo de SIRHS	Autoridades pertinentes de otros organismos relevantes	Autoridades de organismos subnacionales	Gerencias	Autoridades de consejos/colegios profesionales
Liderazgo y coordinación de SIRHS	Unidad Estratégica de RHS		Direcciones subnacionales de primer orden de RHS Áreas subnacionales de segundo orden de RHS (municipales)		
Soporte legal y tecnológico	Áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones Áreas de asuntos legales y jurídicos				
Proveedores de información (registros de referencia)	Dirección de Registro y Control de Profesionales de la Salud Dirección de Habilitación y Acreditación de Establecimientos	Entes reguladores/ acreditadores de profesionales/ establecimientos privados o de la seguridad social	Registros subnacionales de profesionales Registros de establecimientos de salud subnacionales		Consejos/colegios profesionales

CUADRO A3.1. Matriz de relevamiento (continuación)

Categoría	+ Rectoría			- Rectoría	
	Estado			Sector privado/ seguridad social	Sociedad civil
	MS	Fuera del MS	Niveles subnacionales		
Proveedores de información (registros auxiliares)	Dirección de Gestión de Recursos Humanos para las Salud del MS Direcciones de gestión de RHS específicos (p. ej., APS) Dirección de Estadísticas Sanitarias	Ente regulador/ acreditadores de la seguridad social Registros civiles Ministerio de Educación Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Organismos fiscales Organismos de migraciones	Áreas de gestión de RHS	Áreas de gestión de RHS	Áreas de gestión de RHS
Usuarios de datos	Dirección de Planificación Estratégica del MS Otras áreas del MS que planifican, gestionan o monitorean RHS en general o específicos (programas de salud bucodental, nutrición, salud escolar, maternidad e infancia) Áreas de implementación de estrategias de salud digital	Superintendencias de Salud Ministerio de Hacienda Institutos nacionales de estadística Ministerio de Educación Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Otros organismos públicos	MS subnacionales Direcciones de estadística subnacionales Otros	Establecimientos de salud privados Sistemas de prescripción electrónica Plataformas de telemedicina Historias clínicas electrónicas	Investigadores y académicos ONG Ciudadanía en general

APS: atención primaria de salud; MS: Ministerio de Salud; ONG: organización no gubernamental; RHS: recursos humanos para la salud; SIRHS: sistema de información de recursos humanos para la salud.

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de relevamiento basado en el reconocimiento de actores, con énfasis en los proveedores de información de registros de referencia y registros auxiliares.

CUADRO A3.2. Ejemplo de relevamiento de matriz de actores (proveedores de información)

Categoría	Nivel	Sector	Dependencia	Registros asociados
Registro de referencia	Estado nacional	Público (MS)	Departamento de habilitación de establecimientos (públicos)	Registro de establecimientos
Registro de referencia	Estado nacional	Público (MS)	Departamento de registro de profesionales	Registro de profesionales
Registro auxiliar	Estado nacional	Público (MS)	Departamento de RHS	Registro de planteles (públicos)
Registro auxiliar	Estado nacional	Público (sanidad militar/ policial)	Departamento de RHS	Registro de planteles (públicos)
Registro auxiliar	Estado nacional	Público (Ministerio de Educación)	Departamento de titulaciones	Registro de titulados, instituciones
Registro de referencia	Estado nacional	Público (organismo regulador de seguridad social)	Departamento de acreditación de establecimientos de salud	Registro de establecimientos
Registro auxiliar	Estado nacional	Público (registro de personas)	Departamento de registro de las personas	Registro de validación de personas/fallecidos
Registro auxiliar	Estado subnacional	Público (nivel subnacional de primer orden)	MS subnacionales	Registro de planteles, establecimientos, profesionales (subnacional)
Registro auxiliar	Estado subnacional	Público (nivel subnacional de segundo orden)	Departamentos de RHS municipales	Registro de planteles (subnacional - municipal)
Registro de referencia	No estatal	Público (sociedad civil)	Colegios/consejos profesionales	Registro de profesionales
Registro auxiliar	No estatal	Público (sector privado)	Empresas que ofrecen servicios de salud	Registro de planteles (privado)

MS: Ministerio de Salud; RHS: recursos humanos para la salud.

Anexo 4.

Secuencia sugerida para la implementación y el seguimiento de la hoja de ruta del mapeo de actores

A continuación, se presenta una **secuencia** orientativa (cuadro A4.1) para la implementación del proceso, alineada con la guía operativa proporcionada (véase el recuadro 2). Esta secuencia está dividida en momentos y detalla las actividades clave necesarias para llevar a cabo el mapeo, así como los responsables de cada una y los resultados esperados.

La secuencia puede utilizarse como base para la conformación de un diagrama de Gantt que desglose las actividades secundarias en función de los resultados esperados. Además, se recomienda definir indicadores específicos para cada actividad (por ejemplo, cantidad de entrevistas realizadas o número de actores internos identificados) a fin de facilitar el monitoreo y la evaluación del progreso.

Los países adecuarán la secuencia de acuerdo con sus avances previos a la implementación de esta metodología.

Cuadro A4.1. Ejemplo de secuencia para la implementación del mapeo de actores

Trimestre	Actividades principales	Responsables	Resultados esperados
Primer momento	Preparación y planificación - Caracterización del contexto político y estratégico. - Definición de objetivos generales y específicos para el mapeo de actores y el diálogo estratégico en el país. - Establecimiento del equipo coordinador. - Desarrollo de un plan detallado de actividades y recursos necesarios. - Reconocimiento de la estructura política administrativa del país (2.2) y el modelo de atención de salud. - Realización de la autoevaluación utilizando la Guía de Autoevaluación.	Decisores Unidad Estratégica de RHS Equipo coordinador del mapeo	Identificación y comunicación del objetivo político estratégico del mapeo de actores y el diálogo estratégico. Plan de trabajo aprobado. Listado preliminar de actores identificados. Comprensión de la estructura política y modelo de atención del país. Autoevaluación completada.

Cuadro A4.1. Ejemplo de secuencia para la implementación del mapeo de actores (continuación)

Trimestre	Actividades principales	Responsables	Resultados esperados
Segundo momento	Identificación de actores internos del MS para SIRHS - Exploración del organigrama y funciones del MS (2.4.1). - Identificación de Registros de Referencia de Salud (2.4.2). - Identificación de la infraestructura tecnológica dentro del MS (2.5). - Identificación de la normativa y convenios existentes sobre intercambio de datos dentro del MS (2.6). - Elaboración de la matriz de relevamiento de actores internos del MS (2.8). Disponibilidad de datos de registros internos del MS	Unidad Estratégica de RHS Equipo coordinador del mapeo Soporte TIC Asesores legales Proveedores y usuarios de datos internos al MS	Identificación y documentación de actores clave dentro del MS. Registro de áreas encargadas de habilitaciones y acreditaciones. Mesa de trabajo interna del MS. Inventario de la infraestructura tecnológica. Listado de normativas y convenios sobre intercambio de datos existentes. Acuerdos de gestión para integración de datos. Matriz de relevamiento de registros de datos. Definición de la infraestructura tecnológica interna del MS para intercambio de información.
Tercer momento	Identificación de actores externos y registros auxiliares - Identificación de registros auxiliares (2.7). - Elaboración de la matriz de relevamiento de actores externos (2.8). - Realización de entrevistas a actores externos relacionados con registros auxiliares (3.2).	Unidad Estratégica de RHS Equipo coordinador del mapeo Soporte TIC Asesores legales Proveedores y usuarios de datos externos al MS	Listado de actores externos relevantes. Matriz de relevamiento externa completada. Carta de solicitud de entrevistas con actores. Entrevistas realizadas a actores externos de registros auxiliares. Identificación de modelos de convenios.
Cuarto momento	Confección y validación de la matriz de relevamiento de actores - Integración de las matrices internas y externas. - Validación y ajuste de la matriz y diagrama de actores (4.1). - Caracterización de registros recolectados y análisis de calidad de datos (4.2). - Construcción de consensos e instrumentación mediante convenios o acuerdos de gestión (4.3). - Priorización de actores, acciones clave y reconfiguración de hoja de ruta (4.4). - Organización de un taller con todas las áreas internas y externas para validar el mapa de actores y discutir acciones futuras. Disponibilidad de datos de registros externos del MS	Decisores Unidad Estratégica de RHS Equipo de mapeo Asesores legales Actores internos y externos relevados	Matriz de relevamiento de actores completa y validada. Diagrama de flujo de información entre actores. Hoja de ruta reconfigurada con prioridades establecidas. Primera caracterización y análisis de la calidad de los datos disponibles. Taller con participación de todas las áreas internas y externas. Firma de convenios. Definición de infraestructura tecnológica para intercambio de información.

MS: Ministerio de Salud; RHS: recursos humanos para la salud; SIRHS: sistema de información de recursos humanos para la salud; TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones.

La gestión eficaz de los recursos humanos para la salud (RHS) se enfrenta al desafío de la fragmentación de la información. Con el fin de abordar esta problemática, la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta una metodología de mapeo de actores y diálogo estratégico para la gobernanza de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS).

El propósito de esta metodología es la identificación de actores estratégicos, el impulso al diálogo entre ellos y la creación de una ruta de trabajo común con los responsables de datos e información en el ámbito de la fuerza de trabajo en salud. Este mapeo se entiende como un proceso político-técnico en constante evolución y adaptación, basado en el reconocimiento de la interoperabilidad de los sistemas y el establecimiento de acuerdos de colaboración para la gobernanza y consolidación de un SIRHS.

Mediante el aprovechamiento estratégico de distintas fuentes de datos —como los registros administrativos de habilitaciones profesionales, establecimientos de salud y nóminas de personal— y un enfoque sólido en la gobernanza y la coordinación intersectorial, el documento presenta una propuesta de guía operativa con diversas etapas para superar las “islas de datos”. El trabajo apunta a la construcción de un SIRHS escalable y con capacidad sostenida para generar información de calidad para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la gestión de los RHS.



www.paho.org



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas